BICENTENARIO DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CURSO 2:

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y JÓVENES

UNEFCO
Unidad Especializada de Formación Continua

CONTENIDO

CONTENIDO ____ I
PRESENTACIÓN ____ III
DATOS GENERALES DEL CUADERNO ____ V
OBJETIVO HOLÍSTICO DEL CICLO ____ V
OBJETIVO DEL CURSO ____ V
PERFIL DE SALIDA ____ V
Tema 1: PROTECCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA ADOLESCENCIA ____ 1
ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO ____ 3
1.1. LA ADOLESCENCIA DESDE LA PERSPECTIVA GENERACIONAL, DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD ____ 3
1.2. CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ____ 4
1.3. DESARROLLO DE HABILIDADES DE AUTOCUIDADO, CUIDADO Y RESPETO ____ 6
1.3.1. Autoestima, audeterminación y cuidado de la salud sexual y reproductiva ____ 7
1.3.2. Consentimiento y habilidades de rechazo en salud sexual y reproductiva ____ 7
1.3.3. Capacidad crítica y superación de mitos acerca de la sexualidad que impactan sobre la salud sexual y reproductiva ____ 8
ACTIVIDAD PARA EL AULA (Secundaria) ____ 10
ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO ____ 11
Tema 2: EMBARAZO EN ADOLESCENTES ____ 13
ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO ____ 15
2.1. SITUACIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN BOLIVIA ____ 16
2.2. VIOLENCIA SEXUAL Y SU RELACIÓN CON EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES ____ 19
2.3. LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA SOCIEDAD O ENTORNO FAMILIAR HACIA LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS ____ 20
2.4. LA OPINIÓN DE LAS ADOLESCENTES Y SU ENTORNO SOBRE EL EMBARAZO ____ 21
2.5. IMPACTO DEL EMBARAZO EN LA VIDA DE LAS ADOLESCENTES ____ 21
a) La adolescente embarazada se enfrenta a las siguientes consecuencias ____ 22
b) Desde el punto de vista del futuro padre adolescente ____ 23
c) Consecuencias para la hija o el hijo ____ 24
2.6. DERECHO A LA EDUCACIÓN A LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS EN EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR ____ 24

ACTIVIDAD PARA EL AULA (Secundaria) ____ *26*
ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO ____ *27*
Tema 3: PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA, PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLES ____ **29**
ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO ____ *31*
3.1. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA ____ *31*
3.2. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA ____ *32*
3.2.1. Acceso a métodos anticonceptivos (normativa nacional) ____ *33*
3.2.2. Interrupción legal del embarazo (ILE), Sentencia Constitucional Nº 206/2014 ____ *52*
3.3. RESPONSABILIDADES PATERNAS Y MATERNAS: ADOLESCENTES Y JÓVENES (ENFOQUE DE MASCULINIDADES) ____ *57*
3.4. EL PROYECTO DE VIDA COMO PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES ____ *58*
ACTIVIDAD PARA EL AULA - Análisis 1 (Secundaria) ____ *62*
ACTIVIDAD PARA EL AULA - Análisis 2 (Secundaria) ____ *64*
ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO ____ *65*
BIBLIOGRAFÍA ____ **67**

Presentación

En este año histórico, en el que Bolivia conmemora 200 años de independencia, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), asume con firmeza el desafío de transformar la educación en nuestro país.

La UNEFCO, con una trayectoria sólida y reconocida, ha diseñado una estrategia de formación continua innovadora y transformadora, alineada con los principios constitucionales y las demandas actuales del Sistema Educativo Plurinacional (SEP). Nuestro objetivo es claro, empoderar a las maestras/os y actores del SEP como agentes de cambio, capaces de liderar una educación que responda a los desafíos y necesidades de nuestra diversidad cultural.

En este contexto, presentamos las Acciones Formativas, como una propuesta flexible, práctica y profundamente conectada con la realidad de las aulas. El desarrollo de los cursos/ciclos no solo respeta los ritmos y tiempos de cada docente, sino que también les invita a ser protagonistas de su propio crecimiento profesional, con herramientas que les permitan transformar su práctica educativa y, con ella, la vida de miles de estudiantes.

En el marco del Bicentenario, nuestra formación continua se enfoca en dos ejes estratégicos, inspirados en la Agenda Patriótica 2025 y en las prioridades del Ministerio de Educación:

1. Fortalecer las condiciones para una educación de calidad, promoviendo prácticas innovadoras, inclusivas y pertinentes a nuestra realidad plurinacional.

2. Posicionar a la educación como el corazón de la transformación social, reconociendo su poder para construir una Bolivia más justa, equitativa y soberana.

Los cuadernos de formación continua, elaborados por la UNEFCO, más que materiales educativos; son una invitación a la reflexión, innovación y acción. Cada unidad temática está diseñada para inspirar, motivar y proporcionar herramientas concretas que permitan a las y los maestros llevar a sus aulas una educación que trascienda lo convencional y se convierta en un espacio de transformación real.

En este Bicentenario, no solo celebramos nuestro pasado, sino que también miramos hacia el futuro con determinación. La educación es, y será siempre, la herramienta más poderosa para construir la Bolivia que soñamos. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos de maestras y maestros comprometidos e innovadores, capaces de liderar este cambio.

Invitamos a todas y todos los actores del SEP a sumarse a este proceso de formación continua y juntos, construyamos una educación que honre nuestro pasado, transforme nuestro presente y garantice un futuro lleno de oportunidades para las próximas generaciones.

Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO)

Bicentenario de Bolivia: 200 años de lucha, unidad y esperanza

RUTA DE APRENDIZAJE DE LOS CICLOS FORMATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN DESPATRIARCALIZADORA - ITINERARIOS FORMATIVOS PARA MAESTRAS, MAESTROS Y OTROS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL.

DATOS GENERALES DEL CUADERNO

OBJETIVO HOLÍSTICO DEL CICLO:

Afianzar el reconocimiento de la sexualidad como dimensión humana y derecho fundamental, para la formación integral de la comunidad educativa, a través del análisis y reflexión de problemáticas de la comunidad para la construcción de temas y conceptos claves contribuyendo a la implementación de la Educación Integral en Sexualidad desde los Ejes Articuladores y los Campos de Saberes y Conocimientos fortaleciendo principios y valores respetuosos de los Derechos Humanos.

OBJETIVO DEL CURSO:

Analizar, reflexionar y problematizar los estereotipos y mitos sobre la sexualidad que repercuten en el ejercicio de los Derechos Humanos, entre ellos en los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, interiorizando la importancia de la Educación Integral en Sexualidad como base para la construcción de una comunidad pacífica y armónica.

PERFIL DE SALIDA:

Las y los participantes cuentan con competencias para desarrollar y fortalecer habilidades y conocimientos en las y los estudiantes que les permitan prevenir un embarazo no intencional y proteger su salud sexual y reproductiva, en el marco de las políticas de prevención del Ministerio de Educación.

BICENTENARIO DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Tema 1

PROTECCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA ADOLESCENCIA

UNEFCO
Unidad Especializada de Formación Continua

ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO

Antes de iniciar el desarrollo del contenido, es pertinente generar un espacio de reflexión, para ello contestar a las siguientes preguntas:

¿Cómo se dio cuenta de que ya no era niño o niña?

¿Qué sintió o vivió en la adolescencia, con mucha intensidad?

¿Cuándo era adolescente, que pensaban las personas de su entorno sobre la adolescencia?

¿En qué actividades participaba cuando era adolescente?

1.1. LA ADOLESCENCIA DESDE LA PERSPECTIVA GENERACIONAL, DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD

La Organización Mundial de la Salud establece que las personas entre 10 y 19 años son adolescentes. Sin embargo, caracterizar a esta población sólo por pertenecer a una franja etaria deja de lado muchos factores fundamentales para comprenderla.

La adolescencia es más que una sola etapa, cuando pensamos en adolescentes, a menudo imaginamos un grupo de edad específico. Pero ser adolescente es más que solo envejecer. Está moldeado por la cultura en la que vivimos, las personas que nos rodean e incluso el período de tiempo en el que estamos.

Entre la Biología y Sociedad, la pubertad y los cambios físicos son una gran parte de la adolescencia. Pero ¿cuándo realmente termina? ¿Es cuando terminamos la escuela, conseguimos un trabajo o comenzamos una familia? Depende de dónde vivamos y qué espere la sociedad de nosotros. Entonces, mientras la biología nos da un punto de partida, la sociedad establece la línea de meta.

Conceptos erróneos. Aún persisten en el tiempo, la gente ha visto a las y los adolescentes como atrapados entre la infancia y la adultez. A menudo se les ve como malhumorados, indecisos y no del todo adultos. Pero esto no siempre es justo. Las y los adolescentes son individuos únicos con sus propios pensamientos, sentimientos y experiencias.

Desde la Sexualidad y la Sociedad, ser adolescente significa descubrir tu cuerpo y tu lugar en el mundo. Esto incluye explorar la sexualidad. Pero la sociedad envía mensajes contradictorios. Por un lado, estamos rodeados de imágenes de sexo. Por otro lado, a menudo nos dicen lo que es "apropiado" o "inapropiado".

Nuevos cambios, Las y los adolescentes de hoy viven en un mundo muy diferente al de sus madres y padres. La tecnología, la globalización y los cambios en las normas sociales han tenido un gran impacto en cómo crecen las y los adolescentes. Están más conectados que nunca, pero también enfrentan nuevos desafíos.

Adolescentes como pensadores, Las y los adolescentes son capaces de pensar profundamente y razonar de manera compleja. No solo están pasando por una fase; están dando forma activamente a sus identidades. La educación juega un papel crucial en este proceso. Las unidades educativas deben fomentar un ambiente de apoyo donde los adolescentes puedan explorar sus ideas y aprender sobre sí mismas o sí mismos.

En la adolescencia el rol de maestras y maestros es muy importante para promover un proyecto de vida y apoyarlos/apoyarlas en la planificación de las metas a corto, mediano y largo plazo, direccionando todas las energías, hacia el autoconocimiento y confianza en la toma de decisiones. La relación entre estudiantes, maestra o maestro es un vínculo potencialmente inspirador que puede orientar, reforzar y sacar lo mejor de cada adolescente, actuando desde el privilegio y la responsabilidad que supone.

Proyectando el Futuro, A medida que los adolescentes piensan en su futuro, necesitan orientación y apoyo. La educación puede ayudarlos a establecer metas y tomar decisiones informadas. Es importante recordar que cada adolescente es diferente y debe tener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial".

En la práctica educativa se utiliza el concepto de "Proyecto de vida", entendido como un subsistema auto-regulador de la personalidad en el que se integran elementos cognoscitivos e instrumentales y afectivos, motivacionales en determinadas tareas generales a desarrollar en la vida de la persona.

1.2. CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Cuando se es adolescente, el cuerpo y la forma de pensar cambian mucho. Es como si se construyera una nueva casa para sí misma o sí mismos. Pero estos cambios también traen nuevos retos, sobre todo cuando hablamos de cosas como el amor, las relaciones y el cuerpo.

Sabías que...

Organización Mundial de la Salud, la salud sexual se refiere a la integración de elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. En este sentido, el concepto alude a una visión amplia de la salud, que excede lo puramente fisiológico y reproductivo.

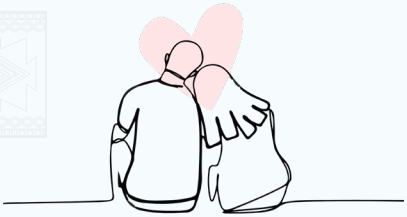
Las y los adolescentes se enfrentan a problemas como:

- Ser obligadas u obligados a tener relaciones sexuales.
- Casarse muy jóvenes.
- Quedarse embarazadas o embarazarse con alguien más sin estar preparadas.
- Enfermedades como el VIH.

Aunque es importante saber sobre estos temas, a veces para las y los adolescentes les es difícil hablar de ello, incluso cuando quieren hacerlo, muchas veces no saben dónde buscar información o sienten pena preguntar. Sin embargo, es importante que las y los adolescentes estén informados para saber cómo cuidarse bien, conocer su cuerpo, su funcionamiento, conocer sobre sus derechos y poder decidir sobre su futuro.

¿Qué es la salud sexual?

Imagen 1: Pareja Romántica



Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/888405463966127010/

La salud sexual es sentirse bien con el cuerpo y las relaciones. Es poder hablar de amor, de respeto y de tomar decisiones libres.

Se tiene derecho a decidir sobre el cuerpo y a vivir sin miedo. Es importante que las personas mayores escuchen y respeten a las y los adolescentes como sujetos de derechos.

Al ser adolescentes, se empieza a sentir cosas nuevas y a tener curiosidad. Es normal tener preguntas sobre el amor y las relaciones. Lo importante es hablar de estos temas con confianza y respeto.

La cuestión de la sexualidad en las y los adolescentes abre un amplio debate en torno al reconocimiento de éstos como seres sexuales.

Es necesario considerar que, en la adolescencia, la sexualidad sigue aún en construcción y que en ese proceso es necesario entablar un diálogo reflexivo con las y los adolescentes con el fin de desmitificar prácticas a las que se dan mucho valor, como el coito, y se olvidan aspectos tan importantes como la autoestima, personalidad y habilidades emocionales, sin olvidar los cambios

biológicos, psicológicos y sociales que se vivencian.

Cuidar la salud sexual ayuda a crecer sanos y felices a las y los adolescentes. Además, permite disfrutar las relaciones y tomar decisiones responsables.

1.3. DESARROLLO DE HABILIDADES DE AUTOCUIDADO, CUIDADO Y RESPETO

Imagen 2: Autocuidado

Fuente: https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-ilustracion-autocuidado_7967255.htm

El autocuidado es una práctica diaria que permite conectar con las necesidades emocionales, físicas y mentales. Al aprender a cuidarnos, también aprendemos a cuidar de los demás con más respeto y empatía La salud sexual y reproductiva implica un estado integral de bienestar físico, mental y social relacionado con el sistema reproductivo. Incluye la capacidad de disfrutar de una vida sexual segura y satisfactoria, decidir libremente sobre la procreación y acceder a información precisa y métodos anticonceptivos seguros y asequibles.

También implica empoderar a las personas para protegerse de las infecciones de transmisión sexual y garantizar que las mujeres reciban atención adecuada durante el embarazo y el parto. Todos tienen derecho a tomar decisiones informadas y libres sobre su salud sexual y reproductiva.

El cuidado de la salud sexual y reproductiva abarca una serie de prácticas y decisiones que son fundamentales para el bienestar integral de las personas. Implica estar informado sobre temas como la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), el uso adecuado de métodos anticonceptivos y la planificación familiar. Es crucial que cada individuo tenga acceso a información precisa y a servicios de salud que respeten su autonomía y dignidad. El autocuidado en este contexto incluye tomar decisiones informadas sobre la sexualidad y la reproducción, así como buscar ayuda profesional cuando sea necesario para garantizar una vida sexual saludable y segura.

Empoderar a las personas para que cuiden de su salud sexual y reproductiva también implica fomentar la autoestima y el respeto propio. Esto significa promover relaciones saludables basadas en el consentimiento mutuo, la comunicación abierta y el apoyo emocional. Los individuos deben sentirse capacitados para negociar prácticas sexuales seguras y para tomar decisiones sobre la planificación familiar que se alineen con sus metas personales y familiares. El autocuidado incluye aprender a reconocer signos de alerta en la salud sexual y buscar asesoramiento profesional cuando sea necesario para prevenir o tratar problemas de salud reproductiva.

Además de la educación y el acceso a servicios adecuados, el autocuidado en la salud sexual y reproductiva también implica adoptar hábitos de vida saludables. Esto puede incluir la práctica regular de chequeos médicos, el manejo adecuado del estrés y la promoción de una alimentación balanceada. El autocuidado abarca el bienestar emocional y físico en todas las etapas de la vida, desde la adolescencia hasta la edad adulta. Es importante que los individuos se sientan empoderadas/os para tomar decisiones informadas y responsables que promuevan su salud sexual y reproductiva a lo largo del tiempo.

1.3.1. Autoestima, autodeterminación y cuidado de la salud sexual y reproductiva

La autoestima juega un papel crucial en el cuidado de la salud sexual y reproductiva, ya que influye en cómo las personas valoran su propio cuerpo, sus decisiones y su capacidad para gestionar su bienestar. Una autoestima positiva puede fortalecer la capacidad de una persona para establecer límites saludables en las relaciones, comunicar sus necesidades sexuales de manera efectiva y tomar decisiones informadas sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar. Promover la autoestima implica fomentar el respeto propio y la confianza en las capacidades individuales para tomar decisiones que beneficien la salud y el bienestar sexual.

La autodeterminación en la salud sexual y reproductiva se refiere al derecho de cada individuo a tomar decisiones informadas y libres sobre su cuerpo y su vida sexual. Esto incluye la capacidad de decidir cuándo y con quién tener relaciones sexuales, así como la elección de métodos anticonceptivos y opciones de planificación familiar que se alineen con sus valores y objetivos personales. Fortalecer la autodeterminación implica proporcionar acceso equitativo a información precisa, servicios de salud y apoyo emocional que empodere a las personas para ejercer su autonomía en materia de salud sexual y reproductiva, garantizando así el respeto a sus derechos y dignidad.

En base a la autodeterminación se podrá construir el proyecto de vida de cada estudiante tomando en cuento sus ámbitos personales, familiares, grupales e institucionales, para la toma de decisiones y ejercicio de autonomía, donde la maestra o el maestro, facilitaran este proceso.

1.3.2. Consentimiento y habilidades de rechazo en salud sexual y reproductiva

El consentimiento es un principio fundamental en el cuidado de la salud sexual y reproductiva, especialmente entre los adolescentes. Implica el acuerdo explícito y entusiasta de todas las partes involucradas en cualquier actividad sexual. La capacidad de dar consentimiento está estrechamente vinculada a la educación y al empoderamiento, ya que los adolescentes deben estar informados sobre sus derechos, las consecuencias de sus decisiones y cómo expresar sus deseos y límites de manera clara. El consentimiento no solo protege la integridad física y emocional de las y los

Imagen 3: Aprende a decir "NO"

Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1934159653437899&id=154491934738022&set=a.1343705289150008

jóvenes, sino que también fomenta relaciones saludables y respetuosas. En este sentido, la educación integral en sexualidad desempeña un papel crucial, al proporcionar a los adolescentes el conocimiento necesario para entender y ejercer su derecho al consentimiento.

Las habilidades de negociación y rechazo son esenciales para la autonomía sexual de los adolescentes. La capacidad de negociar implica que las y los jóvenes pueden expresar sus deseos y necesidades, establecer límites y llegar a acuerdos con sus parejas de manera respetuosa y segura. Por otro lado, la habilidad de rechazo es igualmente importante, ya que permite a los adolescentes decir "no" a cualquier actividad sexual que no deseen participar, sin sentir culpa o presión. Desarrollar estas habilidades requiere un entorno educativo que fomente la confianza y la comunicación abierta, y que proporcione herramientas prácticas para manejar situaciones potencialmente difíciles. Programas de educación sexual que incluyan estos componentes pueden reducir la incidencia de relaciones sexuales no deseadas y mejorar la autoestima y la capacidad de toma de decisiones de las y los jóvenes.

La relación entre el consentimiento, las habilidades de negociación y rechazo, y el cuidado de la salud sexual y reproductiva es profunda y multifacética. Un enfoque integral que incluya la enseñanza de estos conceptos puede llevar a una disminución de embarazos no intencionales, infecciones de transmisión sexual (ITS) y experiencias sexuales no consensuadas. Al empoderar a las y los adolescentes con el desarrollo de las habilidades necesarias, se promueve una cultura de respeto y responsabilidad mutua, crucial para el bienestar general y el desarrollo saludable. Las políticas y programas de salud pública deben priorizar estas áreas para crear un entorno en el que todas/os las y los adolescentes puedan tomar decisiones informadas y seguras sobre su salud sexual y reproductiva.

1.3.3. Capacidad crítica y superación de mitos acerca de la sexualidad que impactan sobre la salud sexual y reproductiva

Existen muchos mitos sobre la sexualidad que tienen un impacto negativo en la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. Estos mitos, que a menudo se difunden a través de la desinformación cultural y social, generan confusión y fomentan prácticas peligrosas. Por ejemplo, las creencias de que los métodos anticonceptivos no son necesarios en la primera relación sexual están muy relacionadas con los altos índices de embarazos tempranos; o

que ciertas prácticas sexuales no transmiten infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden llevar a comportamientos de riesgo.

Además, los mitos sobre la sexualidad a menudo perpetúan estigmas y tabúes que dificultan la comunicación abierta y honesta sobre temas sexuales. Esta represión social sobre la sexualidad puede impedir que las y los adolescentes busquen la información y el apoyo que necesitan, ya sea en la familia, en la unidad educativa o en los servicios de salud. La falta de comunicación directa y la vergüenza asociada con la sexualidad pueden contribuir a la baja autoestima y a la toma de decisiones sexuales mal informadas. Las y los adolescentes que no se sienten cómodos hablando sobre su sexualidad son menos propensos a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, lo que agrava aún más los riesgos asociados y dificulta la atención oportuna.

La perpetuación de mitos sobre la sexualidad también puede tener efectos adversos en la percepción que las y los adolescentes tienen de sí mismos y de sus relaciones. Las normas sociales de género, la masculinidad hegemónica y las expectativas irreales sobre el rendimiento sexual pueden llevar a sentimientos de insuficiencia y ansiedad. En el caso de las jóvenes, los mitos que valoran la pureza y castidad pueden restringir su autonomía y contribuir a dinámicas de poder desequilibradas en sus relaciones haciéndolas más proclives a la manipulación y a la violencia. Para las y los jóvenes, los mitos que promueven la virilidad y la agresividad sexual pueden fomentar comportamientos tóxicos y poner en riesgo su salud y la de sus parejas. Por tanto, es crucial que los programas de educación integral en sexualidad aborden y desmantelen estos mitos, promoviendo una comprensión saludable y objetiva de la sexualidad.

La educación integral de la sexualidad basada en evidencia es vital para contrarrestar los mitos dañinos y garantizar que las y los adolescentes puedan tomar decisiones informadas y saludables sobre su sexualidad. Al proporcionar información precisa y fomentar una cultura de comunicación abierta, se pueden mitigar los efectos negativos de la desinformación y promover el bienestar integral de la gente joven, promoviendo que alcancen todo su potencial.

ACTIVIDAD PARA EL AULA

"Adolescencia y los medios de comunicación"

Objetivo: Analizar la representación social del adolescente en los medios de comunicación contrastando con la su contexto y percepción.

Nivel: Secundaria

Tiempo aproximado: 45 minutos.

Desarrollo:

A continuación se escribe las consignas a ejecutar:

1. Analizamos y reflexionamos sobre cómo los medios de comunicación presentan a las y los adolescentes, en la televisión, revistas y periódicos.
2. Elaboramos afiches teniendo como base las conclusiones de la reflexión anterior; utilizamos como materiales recortes de revistas, marcadores y hojas de diferentes colores.
3. Exponemos los afiches en plenaria y debatimos sobre la temática, haciendo énfasis en la mirada de los medios de comunicación y las representaciones sobre adolescentes.

ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO

Tomando en cuenta el área de saber y conocimiento tiene como maestra o maestro, analizar e identificar en la Planificación Trimestral un contenido o tema en el que podamos incorporar uno o varios de los contenidos desarrollados.

BICENTENARIO DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Tema 2

EMBARAZO EN ADOLESCENTES

UNEFCO
Unidad Especializada de Formación Continua

ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO

Haciendo un análisis de la implicancia del embarazo adolescente, construir un Árbol de Problemas sobre el embarazo en la adolescencia en el contexto donde trabaja como maestra o maestro.

2.1. SITUACIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN BOLIVIA

En el Estado Plurinacional de Bolivia, se registró un incremento del 4,2% desde 1998 a 2008 en el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que ya son madres o están embarazadas por primera vez (Ministerio de Salud y Deportes, 2009); sin embargo, en la última Encuesta de Demografía y Salud [EDSA 2016] registró una disminución de 3.1%. (Instituto Nacional de Estadística, 2017).

Según datos del Servicio Nacional de Información en Salud (SNIS), en la gestión 2021, se registraron en el país más de 38 mil embarazos en niñas y adolescentes, lo que equivale a un promedio de 105 por día; en tanto, en menores de 15, hubo 2.329 gestaciones, un promedio de 6 por día. La mayoría de estos casos fue por violencia sexual.

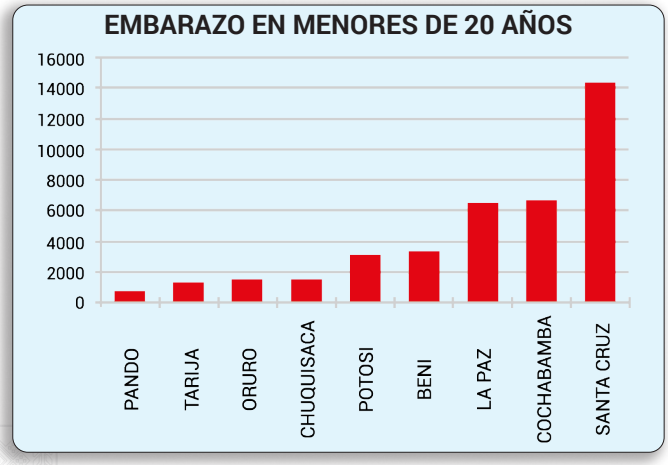
El fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA), indica que el embarazo adolescente e infantil es una de las cinco amenazas contra la vida, la salud y el desarrollo de las niñas y adolescentes bolivianas, además; El matrimonio y uniones tempranas; Violencia sexual y de género; Falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; Y las desigualdades estructurales y la discriminación. La gestación temprana pone en riesgo la vida y salud de las menores, con consecuencias que afectan su desarrollo.

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 2021					
Departamentos	NUEVAS ANTES DE EL 5TO MES DE EMBARAZO A. < 15	NUEVAS ANTES DE EL 5TO MES DE EMBARAZO B. 15 A 19	NUEVAS A PARTIR DEL 5TO MES DE EMBARAZO A. < 15	NUEVAS A PARTIR DEL 5TO MES DE EMBARAZO B. 15 A 19	TOTAL
BENI	322	2010	133	778	3243
CHUQUISACA	75	1101	20	272	1468
COCHABAMBA	181	4547	112	1777	6617
LA PAZ	139	4529	84	1738	6490
ORURO	34	1057	8	342	1441
PANDO	77	504	17	104	702
POTOSÍ	77	2110	47	799	3033
SANTA CRUZ	571	8232	361	5087	14251
TARIJA	52	917	19	280	1268
Total	**1528**	**25007**	**801**	**11177**	**28513**

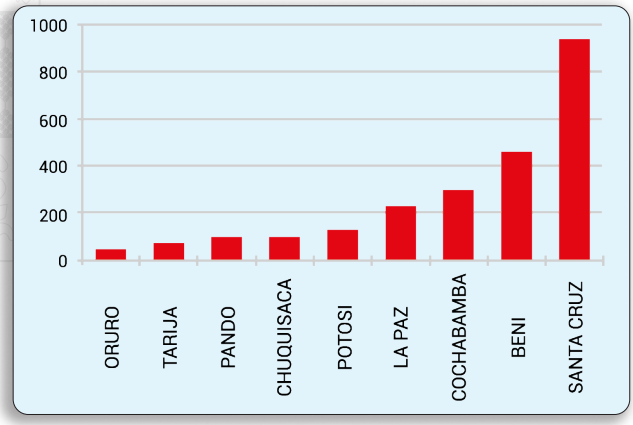
Fuente: SNIS Año 2021

Siempre que hay un derecho, también hay un deber o una responsabilidad. Esto significa que hay "titulares de los derechos" y "responsables de garantizar los derechos". En este punto, el titular de los derechos también se convierte en responsable de garantizar los derechos y debe respetar los derechos de otras personas.

Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos en los que se presenta mayor cantidad de embarazos en menores de 20 años, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:



Santa Cruz y Beni son los departamentos donde se registran más casos de adolescentes menores de 15 años embarazadas (SNIS-2021).



El embarazo en la adolescencia es una situación compleja que debe ser analizada desde un enfoque sistémico, ya que involucra tanto a mujeres como a hombres adolescentes, sus familiares y el entorno social inmediato, así como la disponibilidad de los servicios y la relevancia de las políticas públicas orientadas al bienestar de las y los adolescentes. El embarazo en la adolescencia es considerado por la Organización Mundial de la Salud, como un embarazo de riesgo y en Bolivia, "el porcentaje de muertes maternas en el grupo etario de 14 a 19 años alcanza el 14%. El departamento del Beni es donde se presenta el porcentaje más alto 36%. (Ministerio de Salud, 2016).

Por tanto, el embarazo adolescente es necesario comprenderlo desde

la complejidad de situaciones, emociones y vivencias que se entrelazan. Según el UNFPA, "uno de los factores preponderantes para aceptar tener una relación sexual sin protección es el enamoramiento" 1 (bajo el constructo del amor romántico). Este factor debe entenderse en íntima relación con otros factores que condicen con la situación en la que la adolescente toma sus decisiones, vale decir, el acceder o no a un método anticonceptivo, el decidir utilizarlos o no, el uso incorrecto de los mismos, la falta de información", entre otros.

Conozcamos algunos testimonios de mujeres que vivieron la maternidad en su adolescencia.

> *"Entré en una relación con el papá de mi hija cuando tenía 14 años, a los 15 terminamos, una semana después me di cuenta de que estaba embarazada. Cuando le dije pensó que le decía eso sólo para que regrese conmigo, me dijo cosas que nunca escuché de él, aunque yo todavía lo amaba.*
>
> *Pensé que se le pasaría el enojo y me iba a ayudar, pero no fue así, él conoció a otra chica del mismo colegio y pasaba todos los días con ella.*
>
> *No les dije nada a mis papás; sin embargo, me buscó muchas veces solo por sexo, yo iba con él pensando que de esa forma se haría cargo, pues estaba muy equivocada." (Ministerio de Educación (2016). Munakuyki)*

El aborto inseguro es una respuesta posible frente a un embarazo asociado a algunos de los factores del amor romántico. Los riesgos que implica para la vida y la salud de las adolescentes son considerables, debido principalmente a las condiciones de riesgo en las que se realiza. Las complicaciones comunes de abortos en adolescentes incluyen hemorragias, septicemia, anemia, laceraciones vaginales, abscesos pélvicos, perforaciones del útero y esterilidad secundaria.

> "Es entonces cuando uno piensa y tiene la terrible idea de la solución más rápida que acabaría con las penurias y futuros problemas: el aborto, uno en sus tantos pensamientos que tiene en todo el día le sale esta terrible idea y pues supone que la pareja estaría de acuerdo, lo cual en varios casos se da, pero en otros no, como fue mi caso; no sabía qué hacer tras su respuesta negativa y, entonces, sale otro pensamiento.
>
> Viene a la mente el escape por el temor que se tiene de los padres..." (Ministerio de Educación (2016). Munakuyki)

Pero el embarazo en adolescentes también puede ser consecuencia de una violación ocurrida en el entorno familiar (padres, padrastros, tíos, primos, entre otras.) o por personas desconocidas; la adolescente que es víctima del delito de violación tiene derecho a la Interrupción Legal de Embarazo (ILE), de acuerdo con lo establecido por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0206/2014.

Sabías que...

Siempre hay un derecho, también hay un deber o una responsabilidad.

Esto significa que hay "titulares de los derechos" y "responsables de garantizar los derechos".

En este punto, el titular de los derechos también se convierte en responsable de garantizar los derechos y debe respetar los derechos de las otras personas.

1. Si se ha producido un embarazo a partir de un delito de violación, la víctima y su familia puede, en caso de que así lo desee, hacer la Interrupción Legal de Embarazo en un centro de salud público o privado, presentando únicamente la copia de la denuncia de violación y su consentimiento informado.
2. Si el embarazo genera riesgo para la salud o la vida de la mujer, sólo será necesaria la valoración del médico o servidor de salud y el consentimiento de la mujer para realizar la Interrupción Legal de Embarazo.

2.2. VIOLENCIA SEXUAL Y SU RELACIÓN CON EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Este fenómeno se atribuye a varios factores interrelacionados, que incluyen la falta de acceso a educación integral en sexualidad y servicios de salud reproductiva, el empobrecimiento, pero sobre todo la violencia sexual y la violencia contra las niñas y las mujeres.

Todas estas causas, son producto de las normas patriarcales que perpetúan las relaciones de poder y desigualdad, que, a su vez, producen un mayor riesgo de complicaciones médicas para las adolescentes, abandono educativo y limitaciones en las oportunidades educativas y laborales.

La principal causa de los embarazos en adolescentes es la violencia sexual, hemos visto casos emblemáticos en el país, de niñas y adolescentes que han vivido este gran flagelo al interior de sus hogares, que es donde más seguras deberían estar; incluso, algunas de ellas son obligadas por las iglesias y ciertos sectores conservadores a llevar un embarazo, producto de una violación, a término, constituyéndose en una manera de tortura para sus cuerpos.

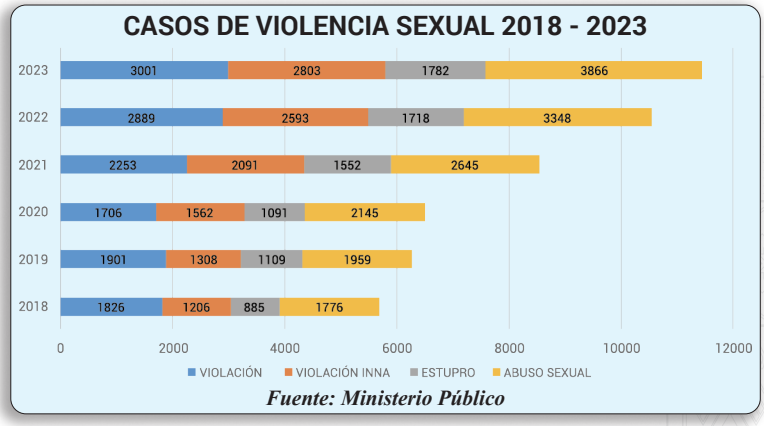
Para prevenir los embarazos en adolescentes, una de las tareas fundamentales es acabar con la violencia sexual, a través de la crianza y socialización de niñas, niños y adolescentes con valores de respeto y la convivencia armónica entre mujeres y hombres.

Otra tarea, igualmente importante, es la incorporación de la educación integral en sexualidad en el currículo educativo, para coadyuvar a evitar situaciones de riesgo a las niñas, los niños y adolescentes y para que las y los jóvenes tomen decisiones informadas sobre su sexualidad, con responsabilidad.

Imagen 4: Imagen de Niñas

Fuente: https://latfem.org/en-la-argentina-cada-3-horas-una-nina-de-10-a-14-anos-es-forzada-a-gestar/

El siguiente cuadro muestra la alarmante cantidad de casos de violencia sexual registrados por el Ministerio Público, y éstos son sólo los denunciados, pues sabemos que muchas de estos delitos nunca son denunciados y quedan en la impunidad.



Fuente: Ministerio Público

2.3. LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA SOCIEDAD O ENTORNO FAMILIAR HACIA LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS

Las y los adolescentes que conforman el grupo de pares de las adolescentes embarazadas, madres y padres adolescentes, desde una visión externa, consideran que las adolescentes embarazadas truncan su vida, frustrando su presente y su futuro y que solo tienen posibilidad de salir adelante aquellas adolescentes que cuentan con el apoyo de su familia y el apoyo de su pareja.

En general, el embarazo en la adolescencia es una situación socialmente rechazada y es considerado como una situación inesperada y decepcionante. La sociedad discrimina a las adolescentes embarazadas en diferentes ámbitos. Por su lado, las adolescentes embarazadas con una actitud de auto-discriminación se retraen en sus hogares y se alejan de las actividades antes frecuentadas, así como de su entorno social.

2.4. LA OPINIÓN DE LAS ADOLESCENTES Y SU ENTORNO SOBRE EL EMBARAZO

A excepción de las madres adolescentes que consideran que tienen la edad adecuada para ser madres ya que previamente vivían en concubinato, ninguna de las adolescentes entrevistadas esperaba ser madre durante la adolescencia.

"Cuando tenía 5 meses de embarazo le conté a mi mamá, ella fue al colegio le reclamó y él simplemente lo negó ante todos, luego mi padre me pegó y se puso a llorar, con mi madre me dijeron que les había fallado, que era muy inmadura para traer un bebé al mundo me quisieron botar a la calle; fue una pelea muy grande, escuché palabras que jamás antes había escuchado, creo que nunca olvidaré ese momento no había sentido tanto miedo en mi vida. Pero gracias a la ayuda de mi abuelita, logré quedarme en casa y seguir con mi embarazo.

¿Cómo te sentiste cuando nació tu bebé?

Me sentí feliz, sentía que yo era importante para ella; cuando la vi por primera vez mi corazón latía tan fuerte y todo cambió desde ese momento; porque yo no podía dormir y mi abuelita era la única que me ayudaba en ese momento, luego mis padres la conocieron y de inmediato se enamoraron de ella y me dijeron que me apoyarían y reconocieron a mi hija como suya.

En esta ocasión conocimos la historia de una niña que se convierte de la noche a la mañana en una persona con grandes responsabilidades que debe luchar día a día para sobrevivir.

Muchas veces la falta de autoestima, falta de comunicación con los padres, falta de información y la falta de criterio formado son las causas de un embarazo en la adolescencia..." (Ministerio de Educación (2016)- Munakuyki).

El objetivo de las adolescentes era ser madres después de culminar una carrera profesional y de tener un trabajo estable. De la misma manera, los padres adolescentes tenían el objetivo de formar una familia después de haber alcanzado una profesión. En ambos casos consideran que la presencia de un hijo o una hija no es impedimento para seguir con los objetivos planeados a futuro; sin embargo, la realidad es que, en varios casos, los papás adolescentes se ven obligados a dejar los estudios por la necesidad de trabajar y mantener a su nueva familia y las mamás adolescentes dejan sus estudios para cuidar su bebé y preocuparse de las tareas domésticas.

2.5. IMPACTO DEL EMBARAZO EN LA VIDA DE LAS ADOLESCENTES

Una adolescente embarazada debe enfrentarse en soledad al impacto de ser la primera persona en conocer su gestación y al miedo a la repercusión de la noticia en su entorno familiar y pareja. En caso de que se decida continuar la gestación se abren varias posibilidades:

Imagen 5: El embarazo adolescente

Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/113948114321378019l/

- Adopción, infrecuente por la dificultad que entraña y las repercusiones emocionales.
- Aceptación del rol de madre soltera, conlleva estigmatización de la sociedad, todavía hoy una madre soltera adolescente se enfrenta a una forma de rechazo social, incluso hasta la familia en algunas ocasiones.
- Formación de un nuevo núcleo familiar de forma independiente o dependiente de los progenitores maternos o paternos:
- En el caso de que la pareja de adolescentes decida formar su propio núcleo, podemos anticipar dificultades en el desarrollo personal de ambos, posibles dificultades económicas en función de las ayudas externas, y falta de habilidades en la crianza de la descendencia.
- Si la pareja opta por la dependencia de una de las familias de origen son previsibles las dificultades económicas, según las posibilidades de dicha familia y las aportaciones propias y como en el caso anterior se produce una interrupción del desarrollo personal de la o el adolescente.

a) La adolescente embarazada se enfrenta a las siguientes consecuencias:

Mayor riesgo desde el punto de vista biológico; cuanto menor es la futura madre, debido a la inmadurez biológica de la misma, mayor es el riesgo, especialmente en edades inferiores a los 15 años.

- Aumento de la mortalidad materna.
- Aborto espontáneo.
- Toxemia gravídica o estado de hipertensión de la gestación
- Distocias por desproporción pélvico-cefálica.
- Hemorragias.
- Consecuencias psicológicas y sociales, resultan más predecibles y constatables. Interrupción ciclo educativo.
- Déficit de formación.
- Dificultad de acceso al mundo laboral.
- Dificultades económicas que ponen en peligro la viabilidad como proyecto familiar y pareja.

- Dificultades relacionales. Rechazo social que puede incluir a la pareja, la propia familia y amistades de la adolescente.
- Mayor índice de depresión y baja autoestima.
- Mayor tendencia a conductas autodestructivas.
- Mayor frecuencia de nuevos embarazos no planificados que agrava la situación de estas mujeres desde el punto de vista físico, psicológico y social.

b) Desde el punto de vista del futuro padre adolescente

En el caso del padre adolescente, las consecuencias están en función del grado de implicación en el proceso. Algunos eluden toda responsabilidad y, salvo en caso de reclamación de paternidad, actúan como si desconocieran que son padres. Otros se implican de una forma total y pueden compartir las mismas consecuencias relativas a lo social y lo psicológico que la futura madre adolescente.

"¿Cuándo nació tu bebé, su papá se hizo cargo?

No porque sus padres afirmaban que mi hijo era de otro, por lo cual no se hizo cargo y decidió entrar al cuartel como un medio de escape.

¿Desde entonces, cuéntanos por lo que pasaste?

Bueno por un tiempo no quise saber nada de él hasta que regresó y volvió a ilusionarme; fue entonces donde decidí dejar mis estudios que mi padre costeaba para irme a Brasil y trabajar para tener una mejor vida junto a mi pareja y mi hijo. Pues no fue así, empezando por mi pareja cambió de carácter de una forma radicalmente agresiva, empezó a maltratarme física y psicológicamente, me abusó sexualmente en estado de ebriedad y drogadicción reiteradas veces hasta que quedé embarazada nuevamente, viendo nuestro estado económico aborté en una clínica clandestina y antihigiénica, allá en Brasil; desde entonces me quise alejar de él. Entre a trabajar planchando telas y todo tipo de ropa, donde no nos daban comida, sólo un pequeño refrigerio que constaba de un plátano y un refresco de néctar con agua cruda, yo no comía por darle a mi bebé e incluso comía la cáscara; mientras yo trabajaba mi bebé dormía en un bañador a falta de una cama.

Junté el dinero suficiente y me escapé del "galpón"; regresé de inmediato a Bolivia, cuando me vieron no me querían aceptar pero mi mamá me perdonó y me aceptó en su casa, para entonces mi hijo ya tenía dos años, pero como siempre con sus condiciones, volví a trabajar y entré a la Universidad Pública de El Alto (UPEA) todo iba bien hasta que regresó el papá de mi

hijo, me reconquistó y me persuadió para que vivamos juntos en un pequeño cuarto, yo estudiaba y trabajaba, pero él sólo trabajaba, y él no quería que siga con mis estudios.

c) Consecuencias para la hija o el hijo

- Incremento de tasas de morbilidad y mortalidad en hijos/hijas de madres adolescentes.
- Posibilidades elevadas de bajo peso al nacer.
- Mayor incidencia de prematuridad.
- Mayor índice de problemas neurológicos.
- Mayor tasa de mortalidad dentro del periodo perinatal.
- Escasos cuidados en su desarrollo físico y psíquicos en la infancia y adolescencia.
- Mayor número de problemas de escolarización y de conductas sociales

2.6. DERECHO A LA EDUCACIÓN A LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS EN EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR

.

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA

Mira el PDF: "***Derechos de las Estudiantes***" de: Ministerio de Educación.

Derechos de las estudiantes

Permanecer en los procesos educativos en periodos de embarazo pre y postparto sin interrupción de sus estudios.

A no ser objeto de discriminación, separación, sanción, expulsión o cambio de unidad educativa.

Recibir una educación con flexibilidad y/o adaptaciones curriculares elaborados por las maestras y los maestros de acuerdo con las licencias temporales.

Participar en las actividades que realiza la unidad educativa al interior o fuera de ella, sin que esto signifique comprometer el embarazo, la salud del binomio madre-niña o niño.

Es importante que las y los integrantes de la comunidad educativa garanticen el derecho de la educación a las estudiantes adolescentes embarazadas como se establece en la Resolución Ministerial N° 2709/2017, promulgada el 17 de octubre de 2017. En el misma reglamenta tanto los derechos de las estudiantes embarazadas y los deberes de la misma y la comunidad educativa.

Deberes de la estudiante	Deberes de la comunidad
a. Cumplir con la presentación de informes, prácticas y trabajos que le asigne la maestra o el maestro de acuerdo con las adaptaciones curriculares en las diferentes áreas de saberes y conocimientos. b. Informar a la directora o el director de la Unidad Educativa su estado de embarazo en forma oportuna y con la documentación correspondiente. c. Asistir al establecimiento de salud correspondiente para los controles de los periodos prenatal y post natal, así como del control de su hija o hijo. d. Cuidar su integridad física y sicológica, evitando situaciones riesgosas y de peligro que puedan causarle daños como también a su hija o hijo.	I. Las autoridades educativas deberán promover actividades curriculares y ferias educativas de prevención con maestras, maestros, estudiantes y padres de familia en educación sexual integral, equidad de género y prevención de violencia y discriminación con el objetivo de reflexionar y concientizar. II. Las autoridades educativas deberán coordinar con los Centros de Salud, Defensorías de la Niñez y Adolescencia y otras instituciones la protección y promoción de los derechos de las niñas y adolescentes en situación de embarazo. III. La madre, padre de familia y/o tutor debe participar en las actividades que convoque la unidad educativa para tratar temáticas de prevención de embarazo y generar comunicación, diálogo y confianza en coordinación con los establecimientos de salud cercano a la unidad educativa. IV. Las estudiantes en situación de embarazo no tienen obligación de usar uniforme en las unidades educativas, fiscales, privadas y de convenio.”

ACTIVIDAD PARA EL AULA

"Historias de la vida"

Objetivo: Reconocer las diferentes circunstancias que se presentan en el embarazo adolescente y posibles alternativas de resolución .

Nivel: Secundaria

Tiempo aproximado: 45 minutos.

Desarrollo:

Formamos tres grupos y distribuimos historias de vida a cada grupo. Pedimos que preparen una escena, representando la situación y luego proponga una posible resolución para la historia. Una vez presentadas las escenas, se abre la discusión, explorando las semejanzas y diferencias entre ellas y las opciones de resolución que fueron sugeridas para cada caso.

HISTORIA 1	HISTORIA 2	HISTORIA 3
Juan y Sonia se conocieron en una fiesta y rápidamente se engancharon. Parecía que se conocían hace mucho tiempo. Conversaron sobre sus gustos, música, lo que querían de la vida y cuando quisieron acordar salir juntos ya se daban besos. Fue amor a primera vista. Esa misma noche tuvieron relaciones sexuales, sin preservativo. Después de esa noche no se vieron más y Sonia descubrió que estaba embarazada.	Paula y Fernando estaban deseando tener un hijo. Un día Paola comenzó a sentirse extraña. Fue al centro de salud y se hizo un test de embarazo dando como resultado: positivo.	Flor y Pedro se enamoraron hace dos años. Planean ingresar a la facultad y disfrutar mucho de la vida! Siempre dicen: "Hijo, ni pensarlo...!" Pero usan preservativo sólo de vez en cuando. Flor tuvo un retraso en su menstruación. Fue al médico quien confirma que está embarazada. Le cuenta a Pedro y ahora no saben qué hacer.

ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO

Reflexionar sobre las disposiciones del "Reglamento para garantizar el derecho a la educación a adolescentes embarazadas":

¿En qué medida se cumple?

Plantear propuestas para su implementación

BICENTENARIO DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Tema 3

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA, PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLES

UNEFCO
Unidad Especializada de Formación Continua

ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO

Antes de iniciar el desarrollo del contenido, es necesario hacer una recopilación de las estrategias de prevención del embarazo adolescente que se hayan aplicado en el accionar como maestras y maestros.

Estrategias aplicadas
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.1. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA

La prevención del embarazo en adolescentes es una prioridad para el Estado Plurinacional y parte de la certeza -ratificada en convenios internacionales- que la Educación Integral en Sexualidad es un derecho humano cuyo ejercicio se traduce en la estrategia más idónea para realizar el proceso de prevención de la violencia, de embarazos no planificados, de las infecciones de transmisión sexual, como el VIH/Sida; asimismo, como garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas.

Para educar eficientemente sobre el tema, se requiere considerar las causas asociadas; el embarazo temprano y no planeado puede ser un síntoma de carencias y situaciones complejas vividas durante la adolescencia temprana. La mayoría de los y las adolescentes no desean un embarazo y saben que no están en la etapa de la vida ideal para ello. Sin embargo, tanto sus antecedentes como la personalidad, los niveles de salud física, psicológica y mental, las presiones a las que se enfrentan, así como el entorno familiar y social interactúan haciendo la realidad más compleja que el simple deseo de retrasar el embarazo.

Es importante que las maestras y los maestros de secundaria tomen en cuenta las circunstancias que impiden a las y los estudiantes tomar decisiones acertadas y actuar eficientemente para evitar el embarazo temprano.

Los y las adolescentes requieren de oportunidades para reflexionar sobre los factores que aumentan las probabilidades de un embarazo temprano. Entre los más significativos encontramos: el consumo de alcohol u otras drogas, la violencia familiar, la violencia en la pareja, las presiones sociales hacia el inicio de las relaciones sexuales, la baja autoestima, las ideas que sustentan

que por amor todo se permite, la ausencia de visita médica, la inequidad, la ausencia de planes de vida y la ignorancia respecto a los métodos para evitar un embarazo.

La Educación Integral en Sexualidad se constituye en la mejor estrategia para prevenir el embarazo en la adolescencia debe enfatizar la responsabilidad de ambos miembros de la pareja, tanto en la elección corresponsable de métodos para evitarlo, como en la discusión sobre los derechos y responsabilidades del hombre y de la mujer ante dicha probabilidad.

Dadas las numerosas consecuencias negativas de un embarazo en la adolescencia, las maestras y los maestros deben desarrollar procesos educativos orientados a la prevención e incrementar las competencias necesarias para postergarlo. Así mismo, es trascendental que maestras y maestros posean conocimiento sobre métodos anticonceptivos, ya que la comunicación errónea sobre los mismos, puede traducirse en un riesgo de salud para las y los estudiantes.

3.2. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA

Las y los Adolescentes

Las intervenciones directas con las y los adolescentes deben partir de las necesidades, expectativas y participación activa de ellos y ellas, considerando las particularidades individuales y la pertenencia cultural. Sera necesario fortalecer sus conocimientos sobre sexualidad, comunicación asertiva, toma de decisiones, proyecto de vida, habilidades para la vida entre otros. En este sentido algunas de las estrategias utilizadas son:

- **Formación de pares (de joven a joven):** Es la estrategia más utilizada para llegar con mayor eficiencia a las y los adolescentes con información clara, completa y neutral brindada por sus pares que son capacitados y capacitadas para este fin.
- **Maestras y maestros,** que no precisamente imparten contenidos de biología o psicología, personas preparadas en la temática, **que llevan mensajes enmarcadas en derechos**, educación laica, el Modelo Educativo Socio comunitario Productivo y en lo posible que hayan trabajado su sexualidad, sus prejuicios, estigmas en diferentes temáticas concernientes a la educación integral en sexualidad.
- **Personal de Salud.** En el país, de acuerdo con el modelo Sociocomunitario Productivo y la SAFCI (Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural), recupera la participación social en los procesos preventivos y de atención en salud-educación. La coordinación con los centros de salud cercanos a los establecimientos educativos se hace necesaria para el **cumplimiento de normativas del país a favor de la prevención de embarazos** en la adolescencia. El trabajo intersectorial es más efectivo a la hora de prevenir los embarazos en la adolescencia.

Entorno de la y el adolescente

El entorno de la o el adolescente es sumamente importante para lograr la integralidad y coherencia en los procesos preventivos del embarazo en la adolescencia. Llámense padres, madres, tutores y comunidad. En este sentido, considerar, como parte de las intervenciones educativas, el trabajo educativo con este entorno será importante para deconstruir conocimientos errados, trabajar tabúes, miedos, prejuicios que genera el hablar de la sexualidad con los hijos, hijas y adolescentes en general, de manera que se entienda la necesidad y los beneficios de abordar temáticas sociales como parte de los procesos de Educación Integral en Sexualidad, para prevenir embarazos en la adolescencia.

Se considera importante el enfoque intergeneracional, perspectiva que reconoce que las y los adolescentes no se construyen de manera aislada y por sí mismas, sino en la interacción constante con el mundo adulto y otras etapas generacionales, donde un elemento de vital importancia es la construcción de puentes generacionales, que permitan la estructuración de relaciones basadas en el respeto, antes que en los estereotipos y abusos de poder. La propuesta es construir un diálogo horizontal entre jóvenes, adolescentes, niñas y niños y personas adultas, como un continuo que apropia espacios formales y no formales; es la incorporación activa de adultos en la transformación de las diferencias creadas por el adulto centrismo que mira a los y las adolescentes y jóvenes como "adultos en formación", con menos derechos y oportunidades de participación (PPEAJ 2015-2020).

3.2.1. Acceso a métodos anticonceptivos

El acceso a métodos anticonceptivos es un derecho reproductivo; sin embargo, una de las barreras más importantes para que se haga efectivo es la actitud de los proveedores, y en general del entorno de las y los adolescentes. Con frecuencia se incurre en intentar disuadir de tener relaciones sexuales, resultando en la mayoría de los casos, en la práctica de relaciones sexuales sin protección.

Las y los adolescentes necesitan información integral y actualizada para que puedan tomar decisiones responsables. En la elección de un método anticonceptivo es imprescindible valorar su accesibilidad y eficacia, realizando una valoración del cumplimiento y la continuidad de uso de un anticonceptivo por parte de la o el adolescente, que supone su empleo correcto, regular y continuo. El cumplimiento depende de las características del método anticonceptivo, además de otros factores externos sociales demográficos.

Se deben considerar las características de los distintos métodos, en función de sus principales características:

- Eficacia: capacidad de impedir la gestación. Se expresa mediante el índice Pearl (técnica estadística que mide la eficacia de los métodos anticonceptivos en estudios clínicos) que indica el número de embarazos

que presentarían 100 mujeres que utilizan un método determinado durante un año.

- Seguridad: efectos secundarios que el método podría provocar sobre la salud de las usuarias o usuarios.
- Reversibilidad: influencia sobre la fertilidad en el futuro. Valora la recuperación de la capacidad reproductiva tras la interrupción de un método determinado.
- Complejidad/facilidad de uso: si el anticonceptivo requiere unos conocimientos profundos sobre el ciclo menstrual, mantenimiento de una rutina diaria o técnicas complicadas en cuanto a su colocación, podría no ser usado adecuadamente.
- Precio: como factor determinante para un uso continuado.
- Accesibilidad del método: indispensable que sea fácil de obtener.
- Aceptación por la pareja: para evitar con ello problemas de abandono en el uso del método.

Métodos anticonceptivos

Los embarazos pueden ocurrir incluso con la primera relación sexual coital sin protección. El embarazo y el parto conllevan riesgos para cualquier mujer, y en particular son de mayor riesgo para mujeres adolescentes, porque su cuerpo aún no ha terminado de desarrollarse.

Un embarazo, ser padre o madre es algo que implica mucha responsabilidad, que conlleva dedicar cuidado, tiempo y amor. Es importante motivar la planificación y la toma de conciencia sobre las dificultades adicionales de vivir un embarazo durante la adolescencia.

Un derecho muy importante es poder decidir si tener hijos/as o no, el número de hijos/as que se quiere tener y el momento más adecuado para tenerlos. Para que las personas puedan gozar de este derecho tienen que acceder a información completa sobre los métodos anticonceptivos y su uso para que elijan el más adecuado para ellas.

Descripción de los métodos anticonceptivos

Antes de evaluar los métodos anticonceptivos, es muy importante poder explorar el concepto de eficacia de estos en cuanto la probabilidad de que se produzcan embarazos no planeados considerando su uso correcto y continuo. Ningún método anticonceptivo alcanza una efectividad del 100%, que solo es posible a través de la abstinencia.

Se enumeran a continuación los métodos anticonceptivos aprobados por el Ministerio de Salud en la Norma Nacional Reglas, Protocolos y Procedimientos en Anticoncepción:

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS NATURALES

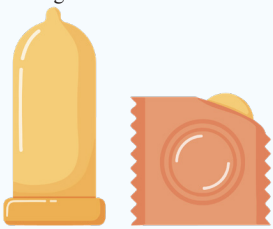
1. MÉTODO DE LA LACTANCIA—AMENORREA (MELA)
2. MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA
    - 2. 1. Método del calendario o método del ritmo (OginoKnaus)
    - 2. 2. Método de la temperatura basal
    - 2. 3. Método del moco cervical (Billings)
    - 2. 4. Método sinto-térmico
    - 2. 5. Método de los días fijos o días estándar
3. MÉTODO DEL RETIRO

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS

1. MÉTODOS DE BARRERA
    - 1. 1. Condón masculino o preservativo

Condón (masculino y femenino): Es el único método que además de protegerte del embarazo, te protege contra las Infecciones de Transmisión Sexual, incluido el VIH.

Imagen 6: Condón masculino



Fuente: https://www.freepik.es/vector-premium/condon-paquete-aislado-sobre-fondo-blanco_32938342.htm#fromView=keyword&page=1&position=19&uuid=716309eb-78e0-44ff-a080-c76dfbac90f3

¿Qué es el condón masculino?

El condón masculino es una funda delgada de látex que se utiliza para cubrir el pene erecto, en cada relación sexual.

¿Cómo funciona?

El condón masculino actúa como barrera y evita la unión de los espermatozoides con el ovulo de la mujer.

8 razones por las que debes usar condón

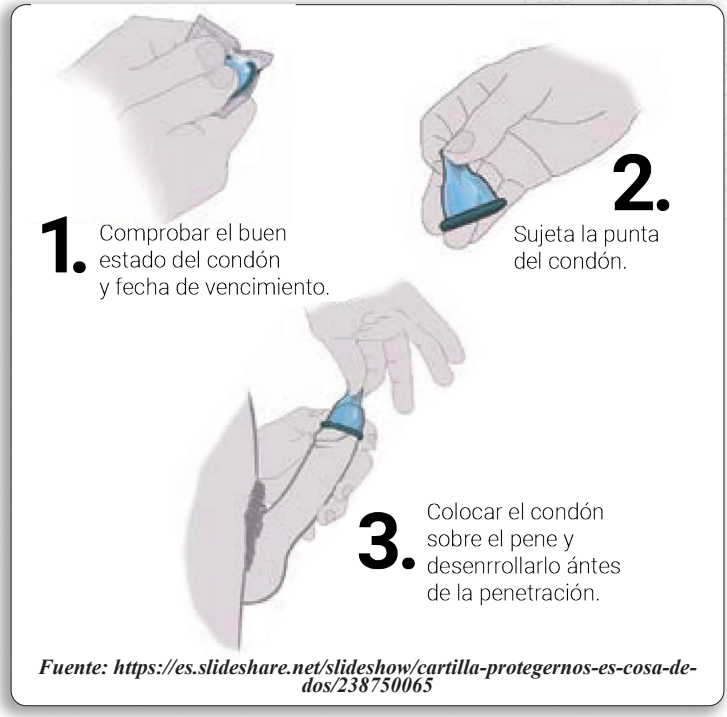
1. El condón es el único anticonceptivo que te protege al mismo tiempo de un embarazo no deseado y de las infecciones de transmisión sexual.
2. El condón es el anticonceptivo más eficaz. Ofrece seguridad por encima de 98% si se usa correctamente.

3. Un condón se utiliza únicamente cuando se necesita, y no produce efectos secundarios.
4. Los condones no influyen en el equilibrio hormonal de las mujeres y las protege del riesgo de contraer el cáncer cervicouterino.
5. Los condones son fáciles de poner. No hace falta consultar a un/a médico/a, basta con leer las instrucciones y hacer una prueba o dos.
6. No hay anticonceptivo más accesible que el condón es el más económico y en los centros de salud pública son gratuitos.
7. Ponerse un condón es un símbolo de cariño ya que demuestra que cuidas a tu pareja.
8. El uso del condón es una decisión inteligente, que beneficia tu salud fomentando la práctica del sexo seguro.

Cuidados del condón

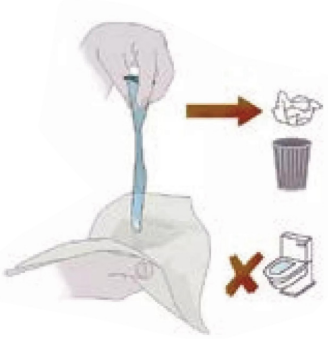
Asegúrate que este lejos de la luz o calor y revisa la fecha de expiración, evita guardar el condón donde pueda dañarse como guantera de auto, billetera o bolsillo.

¿Cómo se usa?



Fuente: https://es.slideshare.net/slideshow/cartilla-protegernos-es-cosa-de-dos/238750065

4. Concluida la eyaculación apartarse de su pareja antes de perder la erección.



5. Retirarlo y desecharlo.

Fuente: https://es.slideshare.net/slideshow/cartilla-protegernos-es-cosa-de-dos/238750065

¿El condón disminuye el placer en la relación sexual?

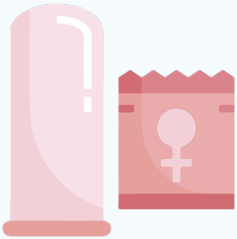
El uso del condón puede ser muy placentero porque te permite realizar juegos eróticos antes de la penetración por ejemplo la mujer puede ayudar a colocar el condón a su pareja. El condón aumenta el placer en las relaciones sexuales al eliminar el temor de un embarazo no deseado o a una infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH.

Dicen que las personas que usan condón no confían en su pareja

No es un problema de confianza, es un problema de salud y protección para ti y tu pareja.

1.2. Condón femenino

Imagen 7: Condón femenino



Fuente: https://www.flaticon.es/icono-gratis/condon-femenino_6850232

¿Qué es el condón femenino?

El condón es el método anticonceptivo de doble protección, previene los embarazos no planificados y la transmisión de ITS-VIH-SIDA.

Es un método de prevención alternativo al preservativo masculino, que protege frente a los embarazos no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Es una funda transparente suave y flexible, esta hecha de un material sintético llamado nitrilo con anillos flexibles en ambos extremos, como un pequeño túnel cerrado en uno de sus extremos.

El anillo de la parte cerrada del preservativo sirve de guía para su colocación en el fondo de la vagina mientras que el otro extremo termina en un aro más grande que queda fuera de la vagina cubriendo los genitales externos de la mujer.

¿Por qué un preservativo femenino?

El preservativo femenino posibilita que las mujeres se protejan así mismas, les facilita la decisión y el control sobre sus relaciones sexuales. Es el único método disponible para ser usado por las propias mujeres y una alternativa adicional al condón masculino.

¿Es un método seguro?

El condón femenino bloquea completamente el paso del esperma y actúa como barrera contra las bacterias o virus que pueden causar la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Su eficacia depende de que se use correctamente. Además es más resistente que el condón masculino.

Parece difícil de usar...

No es difícil de usar, pero se requiere práctica, expertos/as sugieren que debe probarse al menos tres veces para familiarizarse con el.

¿Romperá la espontaneidad?

Puede permitir juegos eróticos previos y posteriores a la penetración sin necesidad de interrumpir la relación sexual ya que puede insertarse desde el principio de la relación, incluso hasta 8 horas antes, puesto que no necesita que el pene este en erección para su colocación.

Permite mantener relaciones sexuales en cualquier posición sin que se produzcan roturas o deslizamientos.

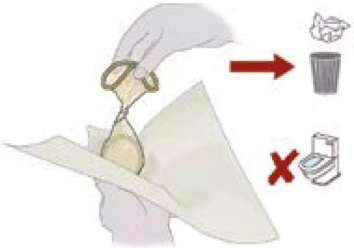
¿Cómo se usa?

1. Comprobar el buen estado del condón.

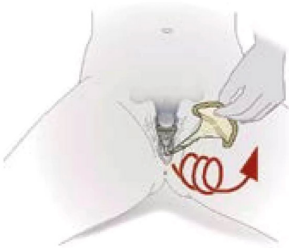
2. Apretar anillo interior, para que se toquen los lados.

3. Insertar el condón tan profundamente como sea posible.

4. Cerciorarse de que el pene entre por el anillo grande.



6. Después de usarlo bótalo a la basura.



5. Retorcer el condón tres veces y retirarlo de la vagina

Fuente: https://es.slideshare.net/slideshow/cartilla-protegernos-es-cosa-de-dos/238750065

¿Qué dicen ellas?

ERIKA

Soy yo la que tiene el control, no corro el riesgo de embarazo, ningún riesgo de contraer infecciones ni VIH, por fin se acabó el problema con las parejas que se niegan a utilizar un condón, ahora yo también decido.

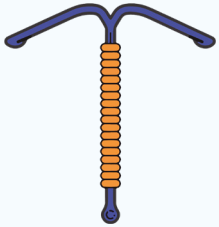
ALEJANDRA

La primera vez que lo vi parecía que era difícil utilizarlo pero ahora me doy cuenta que es mas fácil de lo que pensaba, es muy cómodo y natural, se siente como si no hubiera condón.

2. DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) T de Cobre

T de cobre DIU: Es un dispositivo en forma de T que es colocado dentro del útero. Te ofrece una protección de 12 años.

Imagen 8: (DIU) T de Cobre



Fuente: https://manifiesta.org/t-de-cobre-anticoncepcion-no-debe-doler/

¿Qué es el (DIU)T de Cobre?

Es un pequeño dispositivo de plástico en forma de T, está revestido con cobre y se inserta en el útero de la mujer.

¿Cómo se utiliza?

Este dispositivo debe ser colocado en el útero de la mujer por un/a profesional de salud capacitado/a. Previa valoración de la mujer.

¿Cuánto tiempo lo puedo usar?

Puedes usar la T de Cobre hasta por 12 años. Puedes pedir al/la médico/a que la retire en cualquier momento.

¿Cómo funciona?

La T de Cobre impide que una mujer quede embarazada de dos maneras:

- Primero, actúa como un cuerpo extraño en la cavidad uterina, haciendo que en el endometrio hayan enzimas y prostaglandinas que impiden que los espermatozoides lleguen a las trompas de Falopio.
- Segundo, el cobre actúa como espermicida lo que debilita y mata los espermatozoides.

¿Qué tan efectivo es?

La T de Cobre es uno de los métodos que tienen mayor efectividad para prevenir embarazos. Cuando está bien colocado, la efectividad es cercana al 99% esto quiere decir que si 100 mujeres usaran el DIU de Cobre ("T") durante un año, sólo 1 de ellas podrían quedar embarazada.

Ventajas de la T de Cobre

- No interfiere con las relaciones sexuales.
- No interfiere con la lactancia.
- Efectivo desde el momento que es colocado.
- Independientemente del tiempo de uso, el retorno a la fertilidad es inmediato después de su retiro.
- No tiene ninguna interacción con medicamentos.
- No produce alteraciones hormonales.
- Puedes pedir que te lo coloquen de forma gratuita en cualquier centro de salud público de Bolivia.

¿Cuándo se debe aplicar?

El DIU puede aplicarse durante la menstruación o en cualquier momento, si existe la seguridad de que no hay un embarazo, como puede ser: después del parto, durante una cesárea o después de un aborto (siempre y cuando no hayan infecciones).

El dispositivo no requiere cambios frecuentes ni de periodos de "descanso".

¿Cómo se coloca el DIU T de Cobre?

Un/a médico/a capacitado/a te colocará el DIU en el útero.

Puedes sentir algunos cólicos por unos días después. Esto es normal y desaparecerá. Si sigues con dolores después de unos días, retorna al médico/a.

Cuando acudir al/a médico/a

Deberás acudir a revisión al mes de la aplicación, después de los 3 meses y posteriormente cada año durante el tiempo que decidas usar el DIU T de Cobre.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Es muy probable que tengas cambios en los períodos menstruales.

Algunas mujeres tienen menstruaciones más abundantes o más prolongadas.

¿Me protege del VIH/SIDA?

No protege contra las ITS y el VIH, solo el condón (masculino o femenino) reducen el riesgo de contraer estas infecciones.

Aclaremos dudas y mitos

Mito	Falso
El hombre siente la T de Cobre cuando tiene relaciones sexuales.	No hay ninguna evidencia, a no ser que el DIU esté mal colocado.
Cuando la T de Cobre se queda por mucho tiempo, perfora el útero.	El pequeñisimo riesgo de perforación puede producirse en el momento de colocar el DIU, si se hace de manera inadecuada.
La T de Cobre produce cáncer de cuello uterino	El cáncer de cuello uterino está ligado a una infección por el virus del Papiloma y no al uso de un método anticonceptivo.
La T de Cobre se puede mover y llegar a otros órganos, como el estómago.	El útero no tiene comunicación con los otros órganos del abdomen.

Recuerda:

- La T de Cobre está disponible de forma gratuita en todos los centros de salud pública de Bolivia.
- Puedes hacerte colocar la T de Cobre inmediatamente después del parto.
- La T de Cobre es un método anticonceptivo de larga duración te protege hasta por 12 años.
- Mujeres de todas las edades pueden usar este método previa valoración médica.
- Si es la primera vez que vas a utilizar este método primero debes acudir al/la médico/a de cualquier centro de salud pública de Bolivia para recibir orientación.
- Recibir información clara, comprensible y completa sobre métodos anticonceptivos es tu DERECHO.

3. MÉTODOS HORMONALES

3.1. Métodos hormonales orales: anticonceptivos orales combinados

Píldoras anticonceptivas: Son pastillas que contienen hormonas que se toman cada día para evitar el embarazo. La mujer debe tomar las píldoras diariamente a la misma hora, si se olvida una píldora debe tomarla lo antes posible.

Imagen 9: Píldoras anticonceptivas

Fuente: https://depositphotos.com/es/photos/pastillas-anticonceptivos.html

¿Qué son las píldoras anticonceptivas?

Son comprimidos que contienen hormonas como las producidas por los ovarios de la mujer, estas hormonas son estrógenos y progesterona.

¿Cómo funcionan?

La píldora evita que el óvulo de la mujer madure y salga del ovario. Sin ovulación no hay fecundación por lo tanto no hay embarazo. Además, las píldoras espesan el moco del cuello del útero y modifican el endometrio dificultando así que los espermatozoides lleguen al óvulo.

¿Cuál es su efectividad?

Las píldoras tienen una alta efectividad para prevenir el embarazo, cerca al 99%, si se toman según las indicaciones.

¿Cuáles son los beneficios de tomar las píldoras anticonceptivas?

Las mujeres que usan las píldoras a menudo tienen menstruaciones más regulares y breves. Algunas mujeres sienten que su vida sexual mejora porque se preocupan menos de quedar embarazadas.

Presentación de las píldoras

Las píldoras vienen en un blister de 28 unidades; Las primeras 21, las de color claro se denominan "activas", contienen hormonas y son las que previenen el embarazo. Las últimas 7, las más oscuras, se las denomina "recordatorias", contienen un suplemento de hierro y están ahí para recordarte que tienes que tomar una píldora cada día.

Tu período menstrual comenzará durante la semana en que estés tomando las píldoras "recordatorias".

Cuando termines las 28 píldoras, empieza un nuevo envase.

¿Dónde consigo las píldoras?

Están disponibles de manera gratuita, en todos los establecimientos de salud pública de Bolivia.

¿Cuándo comienzo a tomar mi píldora?

Toma la primera píldora entre el primer y el tercer día de tu menstruación y luego todos los días, tengas o no relaciones sexuales. Lo mejor es tomar la píldora todos los días a la misma hora, de esta manera es más fácil recordar y hacer que sea parte de tu rutina diaria.

Si es la primera vez que tomas las píldoras, la primera semana deberás utilizar otro método anticonceptivo de refuerzo, como el condón femenino o masculino durante la primera semana, porque la protección del embarazo comienza 7 días después de la primera píldora que tomes.

¿Qué molestias puedo tener con la píldora?

La mayoría de las mujeres toleran muy bien las píldoras. Algunas mujeres, sin embargo, pueden sentir molestias leves como nauseas, tensión en los senos o dolor de cabeza. Estas molestias tienden a desaparecer al poco tiempo.

Si las molestias persisten, consulta al médico de cualquier centro de salud público de Bolivia.

¿Las píldoras me protegen del VIH/SIDA?

NO, el único método anticonceptivo que te protege contra esta enfermedad es el condón masculino y femenino. Para tener una óptima protección del embarazo y el VIH/SIDA es mejor usar la píldora y el condón para una doble protección.

¿Cuándo puedo dejar de tomar las píldoras anticonceptivas para embarazarme?

En cualquier momento, pero es mejor hacerlo al final de un envase.

¿Si tomo píldoras anticonceptivas perjudicará mi capacidad de tener hijos/as en el futuro?

NO, el retorno a la fertilidad de la mujer es inmediato.

Qué debes tener en Cuenta?

- Si te olvidas de una píldora y te das cuenta en menos de 12 horas, tómala en cuanto te acuerdes y continúa la toma normal (la siguiente píldora se tomará a la hora habitual).
- Si olvidas tomar alguna píldora y han pasado más de 12 horas, toma la píldora olvidada y la siguiente cuando te corresponda aunque tomes 2 el mismo día.

- Si te olvidas de más de una píldora, debes continuar tomando las pastillas pero el método ya no es totalmente seguro por lo que debes usar otro método de respaldo y consultar con tu médico.
- En caso de vómitos y/o diarreas severas en las primeras 3 o 4 horas después de la toma, debes tomar otra píldora para mantener la eficacia.
- Si tomas otros medicamentos, debes consultar con el/la médico/a para ver si no afecta a tu tratamiento y a la anticoncepción.
- Recuerda siempre consultar a tu médico/a para cualquier duda que tengas sobre el tema o si es la primera vez que vas a utilizar las píldoras anticonceptivas.
- Puedes solicitar las píldoras anticonceptivas de forma gratuita en todos los centros de salud pública.
- El acceso y la elección de que método anticonceptivo utilizar es tu derecho y tu decisión.

3.2. Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE): Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE)

Imagen 10: Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE)

Fuente: https://portaluchile.uchile.cl/noticias/182746/pildora-anticonceptiva-habria-evitado-mas-de-27-mil-hospitalizaciones

¿Qué es la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE)?

Es una píldora hormonal en alta concentración que evita el embarazo. Es un anticonceptivo que previene embarazos cuando se ha tenido una relación sexual sin protección. Esta píldora es conocida como la Pastilla del Día Después o PAE Pastilla Anticonceptiva de Emergencia.

¿Quiénes deben usar la anticoncepción de emergencia?

- Mujeres que tuvieron relaciones sexuales y no utilizaron un método anticonceptivo.
- Cuando una mujer se olvido de tomar sus píldoras el día que tuvo relaciones.
- Si el condón se rompió.

- Se debe suministrar a toda mujer que haya sido víctima de violación.

¿Cómo se usa?

Hay que tomar la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia antes de que pasen las 72 horas después de la relación sexual sin protección.

¿Cómo actúa la PAE?

Si la mujer está en los días previos a la ovulación la PAE evita que el ovario libere un óvulo maduro, sin ovulación no hay embarazo.

Si la mujer ya óvulo la PAE evita que algún espermatozoide fecunde al óvulo.

Si el óvulo ya fue fecundado la PAE impide que se implante en el útero.

¿Qué efectividad tiene?

La PAE tiene una efectividad del 98% cuando se toman adecuadamente.

La PAE puede fallar si no se toma la pastilla a tiempo es decir dentro de las 72 horas después de la relación sexual sin protección.

¡LA SEGURIDAD COMIENZA EN TÍ, PREVIENE EMBARAZADOS NO DESEADOS!

La Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, ¿Es abortiva?

No, no provoca el aborto.

Una vez que una mujer esta embarazada la PAE no es efectiva, pues solo puede actuar antes de que el óvulo fecundado se implante en el útero.

Este método interfiere directamente con el ciclo hormonal del cuerpo de la mujer, por ello no se debe considerara como un método de rutina, pues implicaría estar sometiendo al cuerpo a un descontrol hormonal que con el tiempo puede tener consecuencias negativas.

La PAE no previene de contraer alguna infección de transmisión sexual como el VIH/SIDA, solamente el condón te ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual.

¿Dónde consigo la PAE?

Puedes recibir información, orientación y la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia DE FORMA GRATUITA en todos los establecimientos de salud pública de Bolivia, No te auto mediques.

Recuerda:

- Este método debe iniciarse tan pronto como sea posible dentro de las 72 horas (tres días) posteriores a la relación sexual no protegida.
- Es un anticonceptivo de emergencia. No lo uses como un método de rutina. Es más recomendable usar un método anticonceptivo de forma regular.

- Esta píldora no es abortiva. Si ya tienes retrase en la menstruación, no sirve para provocar el sangrado.
- La pastilla anticonceptiva de emergencia no protege de las enfermedades de transmisión sexual ni de VIH/SIDA.
- Antes de tomar la PAE acude a tu centro de salud para recibir orientación y una valoración previa.

3.3. Anticonceptivos hormonales inyectables de sólo progestina

Inyectables: Son inyecciones que el personal de salud pone cada mes o cada 3 meses, según el tipo.

Imagen 11: Inyección trimestral

Fuente: https://www.alojuntas.com/conoce-las-inyecciones-mensuales-y-trimestrales/

¿Qué es la inyección trimestral?

Es una Inyección intramuscular que contiene una hormona que previene el embarazo durante tres meses.

Esta Inyección también es conocida como la Depo-provera o la Depo.

¿Cómo funciona la inyección anticonceptiva?

La inyección anticonceptiva libera una hormona llamada progestina que impide que los ovarios de la mujer liberen óvulos, no puede haber embarazos si no existe un óvulo que se una con un espermatozoide.

Además, aumenta la densidad de la mucosidad cervical y cambia la cubierta de las paredes del útero, lo cual provoca que sea más difícil que los espermatozoides entren y sobrevivan en el útero.

¿Qué tan eficaz es la inyección anticonceptiva?

Es un método muy seguro si se usa correctamente, cuenta con una efectividad del 99%, lo cual significa que de 100 mujeres que usan este método de manera correcta solo una queda embarazada.

¿Cuáles son las ventajas de usar la inyección anticonceptiva?

No interfiere en la actividad sexual.

Es discreto: solo tú sabes que lo usas.

Es cómodo: su uso se convierte en un hábito muy fácil de seguir, te debes hacer colocar solo 4 veces al año.

Puedes usarla durante la lactancia. La Depo-Provera ejerce su efecto anticonceptivo veinticuatro horas después de aplicada la primera dosis, siempre y cuando se aplique en los primeros días de la menstruación.

El inyectable es un anticonceptivo que debe ser recetado y suministrado solamente por un/a profesional de salud cada tres meses.

¿Cuándo usarlo por primera vez?

La primera inyección se coloca dentro de los primeros siete días del ciclo menstrual, en el brazo o en el glúteo.

¿Cómo usarlo después del embarazo o después de un aborto?

A partir de la sexta semana si su bebé además de la lactancia recibe otro alimento.

A partir de los 6 meses si la lactancia es exclusiva y no ha tenido menstruaciones.

Inmediatamente después de haber sufrido un aborto.

¿Qué hacer si olvidas usarlo?

Si la mujer deja pasar más de 3 meses entre una inyección y otra o más de 6 semanas después del parto, el médico debe terminar que no está embarazada antes de colocar una nueva inyección.

Mito	Falso
La falta de menstruación por haber usado Depo-Provera significa que el cuerpo se está llenando de sangre mala.	La suspensión de la menstruación no hace ningún daño y no significa que el cuerpo se está llenando de sangre, al dejar de colocarse la inyección la menstruación volverá a ser normal.
El anticonceptivo inyectable produce cáncer.	El anticonceptivo ayuda a protegerse contra ciertas formas de cáncer femenino.

Recuerda:

- Mujeres de cualquier edad, hayan tenido hijos o no, pueden usar el inyectable trimestral.
- La Depo-Provera tiene como propósito evitar el embarazo. **No protege contra Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), ni contra el VIH/SIDA,** solamente el condón puede evitar la transmisión de estas infecciones.
- El acceso y la elección de que método anticonceptivo utilizar es tu derecho y tu decisión.

3.4. Implantes

Implante Subdérmico: Son dos varillas del tamaño de un fósforo, que se coloca en la cara interna del brazo de la mujer y libera una hormona que inhibe la ovulación. Sin ovulación no hay fecundación, por lo tanto, no hay embarazo.

Imagen 12: Implante anticonceptivo

Fuente: https://enfamilia.aeped.es/vida-sana/implante-anticonceptivo

¿Qué es el Implante Anticonceptivo?

Son dos tubitos flexibles del tamaño de un fósforo que el médico coloca debajo de la piel del brazo de una mujer. Contiene una hormona que evita que la mujer ovule y previene el embarazo.

¿Quiénes pueden usar el implante?

Todas las mujeres en edad fértil con vida sexual activa pueden usar el implante.

¿Cuánto tiempo lo puedo usar?

Puedes usar el implante entre 4 y 5 años. Puedes pedir al médico que lo retire en cualquier momento.

¿Cómo funciona?

Poco a poco, libera una hormona que funciona de dos maneras:

Impide que el óvulo salga de los ovarios de la mujer. Sin ovulación no hay fecundación, por lo tanto no hay embarazo.

También, hace que el moco del cuello del útero sea más espeso y pegajoso lo que dificulta el ingreso del esperma.

Esto impide que los espermatozoides del hombre entren al útero y se unan con un óvulo, si el esperma no puede unirse con el óvulo, la mujer no puede quedar embarazada.

¿Cuál es su efectividad?

- Es efectivo desde las 24 horas de su aplicación, pero se recomienda que se espere 10 días para su completo funcionamiento.
- El implante es uno de los métodos que tiene la mayor efectividad.
- Si 2.000 mujeres usaran el implante durante un año, solo 1 de ellas podría quedar embarazada. ¡Eso es mucho menos del 1%!

¿Cómo y dónde se aplica el implante?

Se aplica de forma subdérmica (debajo de la piel) en la cara interna del brazo, su aplicación se realiza con anestesia local.

La aplicación es rápida y sencilla, realizada por personal médico capacitado.

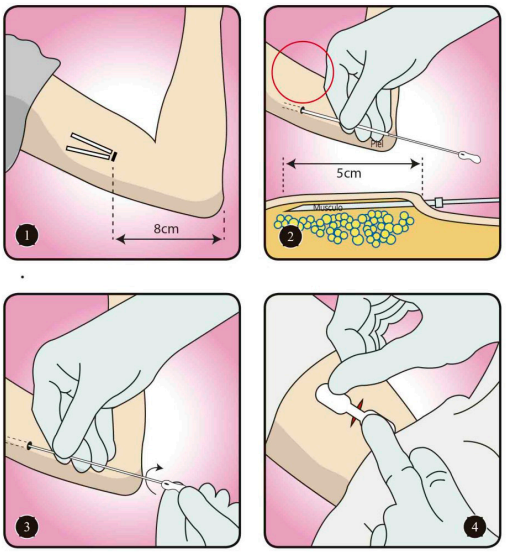
La aplicación se realiza en el consultorio médico (puedes preguntar en el centro de salud más cercano a tu casa si dispone de este método) y no requiere de hospitalización.

Después de la aplicación se podrá generar con normalidad a las actividades diarias.

¿Cuándo se debe aplicar el implante?

El médico coloca el implante durante los primeros días de la menstruación.

¿Cómo se coloca el implante?



Fuente: https://www.revistareportemedico.com/implante-subdermico-anticonceptivo-otra-opcion-mas-para-ti/

¿Qué cuidados debes tener después de la aplicación del implante?

El área donde se aplicó debe mantenerse seca por 24 horas.

Se debe aplicar un vendaje sin demasiada presión en la zona, conservándolo durante 24 horas.

Hay que evitar tocar y golpear el lugar de la inserción del implante.

En ocasiones aparece un pequeño moretón, el cual desaparece sin causar mayores complicaciones.

Ventajas de usar Implante

- Dura hasta por 5 años.
- La fertilidad regresa inmediatamente después de remover los implantes.
- Puede ser insertado durante la lactancia.
- No interfiere en las relaciones y el acto sexual.
- Puede extraerse en cualquier momento, si así lo desea la usuaria.
- Es discreto, solo tú sabes que lo llevas.

Preguntas frecuentes sobre el implante

- **¿El implante anticonceptivo puede perderse en mi cuerpo?**

  No, Poco tiempo después de la inserción se formara una pequeña capa de tejido alrededor del implante, la cual mantendrá el implante en su lugar de inserción.

- **¿Se puede romper?**

  No, hasta la fecha no se ha reportado la ruptura de un Implante.

- **¿Cualquiera será capaz de ver el implante anticonceptivo en mi brazo?**

  No se puede ver. Sin embargo, tú misma podrás palparlo con la punta de tus dedos y cerciorarte que está allí.

- **¿Necesitaré visitas regulares a mi médico?**

  Si, es necesario que continúes con las visitas de rutina con tu médico/a, quien será el mejor apoyo para ti. Si tienes alguna duda, siempre debes consultar con él/ella.

- **¿Cómo recordaré cuándo debo retirarme el implante anticonceptivo?**

  Cuando se inserta el implante anticonceptivo, obtendrás una "tarjeta de recordatorio" en la cual se anotará la fecha de aplicación y la fecha en la cual deberá ser removido. Manteniendo ésta tarjeta, recordarás cuándo debe ser retirado.

- **¿Puede funcionar el implante anticonceptivo como un método de anticoncepción definitivo?**

  No, el implante es un método temporal para uso de 4 a 5 años.

- **¿El implante protege contra el VIH/SIDA?**

  No, solo el condón te ayuda a prevenir el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA.

Recuerda:

- El implante Subdérmico puede ser utilizado por mujeres en edad fértil que hayan tenido o no hijos/as.
- El implante puede ser retirado en el momento que tu lo desees.
- El implante Subdérmico es suministrado de forma gratuita en todos los centros de salud pública de Bolivia.
- El acceso y la elección de que método utilizar es tu derecho y decisión.
- Recibir información clara, comprensible y completa sobre métodos anticonceptivos es tu DERECHO.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PERMANENTES

1. ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA

   1.1. Salpingoclasia OTB

   1.2. Vasectomía

Invitamos a todos y todas las participantes a revisar la NORMA NACIONAL REGLAS, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS EN ANTICONCEPCIÓN.

Es fundamental conocer la información que sea científica, objetiva de forma detallada y completa sobre métodos anticonceptivos, porque brindar una información parcial o errada generará consecuencias para la o el adolescente que desee acceder a un método anticonceptivo, generando fallas en su uso.

3.2.2. Interrupción legal del embarazo (ILE), Sentencia Constitucional Nº 206/2014

Muchas adolescentes intentan una interrupción del embarazo, sin embargo, al ser penalizado en Bolivia, se realiza en condiciones de alto riesgo. Según el Estudio Nacional de Mortalidad Materna (Ministerio de salud, 2016).

- 160 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, la más alta de la región.
- El 14% de las muertes maternas en Bolivia corresponden a adolescentes entre 14 a 19 años.
- El 13% de las muertes maternas son por aborto inseguro, siendo la tercera causa de mortalidad materna.

El problema del embarazo no planificado en la adolescencia podrá reducirse cuando se fortalezca la aplicación del Art. 66 de la Constitución Política del Estado que garantiza a mujeres y hombres sus derechos sexuales y derechos reproductivos; por tanto, exige el empoderamiento de las y los adolescentes a través del acceso a servicios amigables y a una Educación Integral en Sexualidad que conduzca a la eliminación de la violencia basada en género. Las estrategias de prevención deben considerar un enfoque sistémico vinculandose con programas sociales educativos y de salud que involucre a todos los actores sociales e impulsando la responsabilidad de mujeres y hombres por igual.

Existen políticas públicas de salud, que constituyen un potencial muy importante para prevenir embarazos en la adolescencia y para disminuir el índice de mortalidad materna en la adolescencia. La promoción y difusión serán fundamentales para dar una respuesta efectiva y sostenible al embarazo en la adolescencia.

¿En qué casos se puede acceder a la ILE?

En Bolivia solo se puede acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de acuerdo con lo establecido en la Sentencia Constitucional 0206/2014, donde se reconocen las siguientes causales:

- Violación o estupro
- Incesto
- Riesgo de salud o en la vida de la madre
- Malformaciones congénitas

La víctima puede, en caso de que así lo desee, hacer uso de la ILE en un centro de salud público o privado, presentando únicamente la copia de la denuncia de violación y su consentimiento informado.

¿Cuáles son los avances más significativos de la Sentencia 0206/2014?

Se establece la despenalización parcial del aborto. Al reconocer la legalidad de la interrupción del embarazo (ILE) en casos de violación, incesto, estupro y riesgo para la salud o vida de la mujer, la Sentencia ratifica que no existe una penalización absoluta del aborto en Bolivia, por eso no puede existir ningún tipo de retroceso, restricción o límite y mucho menos se puede derogar el tipo penal de aborto impune.

- Elimina las barreras legales para acceder a un aborto legal y seguro cuando el embarazo sea resultado de violación, incesto, estupro o riesgo para la vida o salud de la mujer.

Sabías que...

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 no establece tiempo gestacional para la realización de una ILE.

- En el caso de las mujeres cuya vida o salud corra riesgo como consecuencia del embarazo, sólo será necesario el informe médico. En ambos casos es importante el consentimiento de la mujer.

¿Qué requiere la mujer que ha quedado embarazada como resultado de la violación, para interrumpir su embarazo de forma legal?

El único requisito es la presentación de la copia de denuncia de violación realizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o la Fiscalía, donde no hubiere ninguna de estas autoridades, deberá ser efectuada ante la Autoridad de la Comunidad respectiva y el consentimiento de la víctima.

La copia de esta denuncia es el único requisito que el médico le solicitara para proceder con la interrupción del embarazo.

Con la Sentencia, las víctimas de violación NO REQUIEREN contar con ninguna autorización judicial, norma o reglamento previo.

¿En caso de que el embarazo genere riesgo para la salud o la vida de la mujer, qué se requerirá para interrumpir el embarazo de forma legal?

Sólo será necesaria la valoración del médico y el consentimiento de la mujer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el estado de bienestar biológico, psicológico y social. Bajo esta definición, los embarazos que afecten la salud biológica, la salud mental y/o social de la mujer, constituyen causales para la interrupción del embarazo.

¿Qué sucede si el prestador de salud o la autoridad competente se niega a realizar la interrupción del embarazo?

La Sentencia es de cumplimiento obligatorio para médicos/médicas, policías, fiscales, trabajadoras/es sociales, psicólogas/psicólogos, personal de salud y cualquier otra autoridad competente en el tema.

Si una o un funcionaria/o público o privado, o un profesional médico no cumplen con la Sentencia, se podrá efectuar una denuncia ante el Tribunal Constitucional y remitir estos antecedentes al Ministerio Público, acarreando esto una responsabilidad penal para el que no cumple.

El incumplimiento de las resoluciones constituye un delito contemplado en el artículo 179 bis del Código Penal y, como consecuencia, una persona pueda ser sancionada con reclusión de dos a seis años y con multa de cien a trescientos días.

Sin embargo, es necesario indicar que existe la "objeción de conciencia" el Procedimiento Técnico señala que la o el médico debe comunicar de manera escrita e inmediata, a la o el jefe de Servicio y/o la directora o el director del establecimiento de salud, su imposibilidad de realizar la ILE, para que tomen los recaudos pertinentes y garanticen la prestación del servicio dentro de las 24 horas de haber sido solicitado. La objeción de conciencia no es una decisión institucional sino PERSONAL, y deberá ser comunicada por escrito.

¿En el caso de niñas y adolescentes o personas con discapacidad mental que están todavía bajo la tutela de sus padres o tutores, cómo se aplicaría la Sentencia?

La Sentencia Constitucional establece claramente que el requisito para acceder a un aborto es el consentimiento de la mujer (niña, adolescente, joven, adulta). Para cumplir con lo establecido en la Sentencia el Ministerio de Salud promulgó el "Procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014" (Ministerio de salud, 2015) que establece en su Artículo 8. Obligaciones de los Proveedores de los Servicios de Salud, en sus parágrafos:

a. Realizar la interrupción del embarazo a sola presentación de la copia de la denuncia por violación realizada en cualquiera de las siguientes instancias: Fiscalía, Policía o Autoridades Originarias o Competentes, sin ningún otro requisito o justificación alguna dentro de las 24 horas de haberse realizado la solicitud por la paciente.

b. Interrumpir el embarazo cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro o existan malformaciones congénitas letales de acuerdo con el informe médico, siempre y cuando firme el Consentimiento Informado de manera libre, voluntaria y sin ningún otro requisito.

c. Respetar y garantizar la confidencialidad y privacidad con un trato digno.

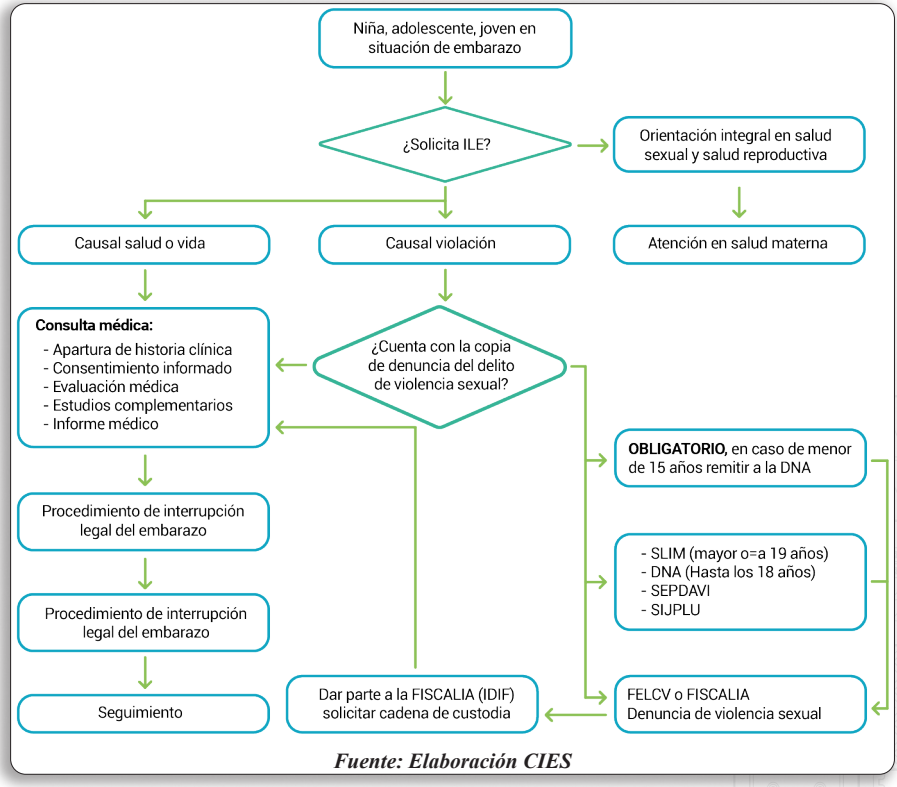
d. Respetar la integridad física y mental garantizando los derechos de las mujeres.

e. En caso de que la usuaria sea menor de edad será atendida presentando la copia de la denuncia de violación, la firma del consentimiento informado pudiendo o no ser acompañada por una persona mayor, tutor, padres.

f. En caso de que la usuaria se encuentre con discapacidad mental ser atendida presentando la copia de la denuncia de violación, pudiendo no ser acompañada por una persona mayor, tutor, padres.

¿Cuál es la ruta que se debe seguir para acceder a la interrupción legal del embarazo?

La ruta que se debe seguir para acceder a la interrupción legal del embarazo, en el marco de la Sentencia Constitucional 0206/2014.



Fuente: Elaboración CIES

La ruta para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) varía dependiendo de la edad de la menor. Las diferencias clave se centran en la necesidad de un procedimiento más expedito y con mayores garantías de protección para niñas menores de 15 años. Para estas, se prioriza la evaluación psicológica y el acompañamiento especializado, considerando que se encuentran en una etapa de desarrollo más vulnerable. También se da mayor énfasis en la participación de tutores legales y en un enfoque que resguarde su integridad y derechos.

Fuente: Defensoría de Pueblo

3.3. RESPONSABILIDADES PATERNAS Y MATERNAS: ADOLESCENTES Y JÓVENES (ENFOQUE DE MASCULINIDADES)

Cuando sobreviene un embarazo en una pareja adolescente, impone una sobre adaptación a esta situación para la cual no están emocional ni socialmente preparados. Cuando una adolescente está embarazada, en muchos algunos casos la noticia es recibida con evidente disgusto por su compañero, su familia y su entorno social (unidad educativa, trabajo). No hay datos acerca de que la maternidad en la adolescencia sea bien recibida en ningún grupo de la mayoría de las sociedades actuales.

¿Qué pasa con el padre?

El adolescente padre en general suele tener menos información que sus compañeras sobre el proceso biológico general y la noticia de ser padres suele conmoverlos profundamente. Deben en ese momento asumir un rol que en esa etapa de su crecimiento está cuestionado. Algunos adolescentes lo intentan, pero la desvalorización a la que son sometidos por sus propias familias, las dificultades laborales y económicas, el rechazo social y la relación de conflicto que se establece con su compañera, hace que muy pocos puedan asumir y mucho menos concretar la responsabilidad. Se convierten así en padres ausentes, con posibles secuelas hasta la fecha no bien estudiadas. Por ello, el padre adolescente, en esta compleja problemática, es una persona que también requiere ser atendida y considerada.

3.4. EL PROYECTO DE VIDA COMO PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

La planeación involucra todas aquellas acciones que determinan los objetivos para el futuro y los medios apropiados para conseguirlos. El planteamiento también considera los objetivos, las acciones, los recursos y la implantación, así como los pronósticos del futuro y el presupuesto.

El Proyecto de Vida, esencialmente debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Es una filosofía de vida representada por los valores y principios que animan la existencia humana y que orientan las grandes decisiones existenciales, así como las opciones del día a día.
- Engloba actitudes, creencias y formas de comportarse o actuar, que posibilitan un sentido de prevención para enfrentar las contingencias de la vida cotidiana.
- Es un proceso permanente que ayuda a tomar decisiones.
- Es un hábito de vida que al ponerlo en práctica cada día ayuda a tener mayor control y autonomía, respecto al entorno.
- Es una técnica que ayuda a alcanzar los objetivos de la vida.
- Una experiencia del pasado y conocimientos del presente, para proyectar el futuro mediante la formulación y realización de los objetivos de vida en relación con las condiciones del entorno.
- Para poder llevar adelante un Proyecto de Vida, es necesario contar con una estrategia. La estrategia, es la forma en la que se desarrolla y mantiene la relación entre los recursos individuales y las oportunidades del entorno, para llegar a los objetivos propuestos.

El proyecto de vida es importante para:

- Descubrir a plenitud el sentido de la vida.
- Orientar con inteligencia y creatividad las decisiones y acciones.
- Definir el liderazgo personal.
- Preparar las condiciones para asumir liderazgo social.
- Construir el futuro día a día.
- Mejorar la autoestima.
- Usar racionalmente y de manera realista los propios recursos.
- Afirmar la conducta asertiva.
- En términos individuales y de ayuda al desarrollo de habilidades, permite: Identificar, analizar y evaluar las competencias propias: fortalezas y debilidades.

- Reconocer, analizar y evaluar factores del entorno: oportunidades y riesgos y amenazas.
- Aplicar una mirada integral y comprender el todo, sus relaciones con y entre las partes.
- Desarrollar el pensamiento creativo, para crear progresivamente el presente y futuro personal.
- Poseer información amplia y actualizada del entorno.

Las preguntas fundamentales para la construcción de un Proyecto de Vida son:

1. ¿Qué? Ayuda a determinar nuestro objetivo de vida.
2. ¿Por qué? o ¿Para qué? Ayuda a establecer las razones o la justificación de nuestro objetivo de vida.
3. ¿Cómo? Ayuda a definir la estrategia, los pasos para llegar a nuestro objetivo de Vida
4. ¿Cuándo? Ayuda a delimitar el tiempo para el desarrollo de nuestra estrategia, los plazos en los cuales llevaremos adelante el Proyecto de Vida.
5. ¿Quién? o ¿Quiénes? Ayuda a establecer a los y/o las responsables de llevar adelante la estrategia o las tareas definidas para llevar adelante el Proyecto de Vida.
6. ¿Dónde? Permite establecer un escenario específico en el que se llevará adelante el Plan de Vida.
7. ¿Cuánto? Permite especificar los recursos (materiales, individuales, conjuntos) que son necesarios para llevar adelante el Proyecto de Vida .

Existen además cinco características de vida fundamentales, para plantear y llevar adelante un Proyecto de Vida, estas son:

1. **Autoestima:** La persona se valora, respeta y acepta a sí misma, en relación con sus características individuales, es consciente que vale por su humanidad, por el simple hecho de existir, para desarrollarse al máximo de sus potencialidades.
2. **Visión:** La persona tiene en su mente y espíritu un horizonte de desarrollo futuro, iluminado por sus sueños que construye en el presente con sus propias decisiones y acciones.
3. **Propósito:** La persona siente que su vida tiene una finalidad y se plantea objetivos de desarrollo que contribuyen a darle sentido y plenitud a su existencia.
4. **Compromiso:** La persona se entrega a sí misma en cada cosa que hace, le pone su propia firma a sus realizaciones y logra expresar su individualidad con el sello de su carácter.

5. **Contribución:** La persona es consciente de que vive en una comunidad y que desarrollándose a sí misma puede y debe realizar aportes que beneficien también a los y las demás.

Las diez razones para llevar adelante un Proyecto de Vida son:

1. **Decisión propia:** la calidad de vida que una persona pueda lograr en el transcurso de su existencia depende de sí misma, de las decisiones que toma en el día a día y en base a las cuales construye su presente, entonces se construye la vida por decisión propia.
2. **Responsabilidad social:** La vida se construye en relación con una/ uno misma/mismo, las y los demás. Cada persona debe aprender a ser responsable de su propia vida, los/las demás no son responsables de la propia vida, sino cada uno con lo que hace o deja de hacer.
3. **Personalidad individual:** La vida de cada uno/una es una oportunidad única, pues no podrá repetirse, ni existirá la posibilidad de rehacer lo que hicimos. De esta manera si una persona no se siente cómoda con su vida, es su responsabilidad tratar de cambiar su papel, hacer todo lo posible para lograr aquello que desea.
4. **Respeto a sí mismo, misma:** La vida es el bien más preciado que se posee, sin ella es imposible conocer, disfrutar, convivir, compartir. El respeto a la vida implica su cuidado y valoración.
5. **Afirmación de sí mismo, misma:** Es una forma de sentar presencia de nuestra existencia en el mundo, a través de nuestras relaciones y nuestra identidad. Afirmarse es dejar huella, es construir nuestra vida desde nuestro punto de vista, con nuestros anhelos, ideales y objetivos.
6. **Motivación de logros:** Es un hecho que existe una diferencia entre lo que se es y lo que se quiere llegar a ser, esa diferencia debe actuar como un motivador para la consecución de logros, para cerrar la brecha hacia aquello que aspiramos a ser.
7. **Oportunidad de realización:** Cada persona tiene un determinado límite de tiempo para lograr realizarse, determinado por la naturaleza y por las condiciones de vida. Ese límite de tiempo es aquel en el que debemos desarrollar todo nuestro esfuerzo para convertirnos en lo que anhelamos, es una oportunidad que no se puede desperdiciar.
8. **Visión de futuro:** Cada persona sueña con un futuro, ese sueño debe ayudar a definir sus acciones, debe ayudar a que cada uno tome su propio rumbo aprovechando sus fortalezas y superando sus debilidades, explotando sus oportunidades y evitando los riesgos innecesarios, es así como cada una/uno se convierte en un individuo autónomo.
9. **Proyecto de Vida:** La vida es un proyecto que a cada persona le corresponde llevar adelante, posiblemente ya no se pueda hacer nada por el pasado, pero siempre se puede hacer mucho por el futuro.

10. **Velocidad del cambio:** La persona, no vive sola, ni aislada, se encuentra en un contexto cada vez más cambiante, interconectado e interrelacionado, eso plantea un escenario en el que debe ajustarse rápidamente a estos cambios, para entregar a otros/as, sobre todo a quienes le son más cercanos, a quienes más quiere, lo mejor que tenga para darles.

ACTIVIDAD PARA EL AULA

"Análisis 1"

Objetivo: Análisis sobre la problemática del embarazo adolescentes y el ejercicio de derechos tomando el marco legal existente en el país.

Nivel: Secundaria

Tiempo aproximado: 90 minutos.

Desarrollo:

Se formarán cinco subgrupos.

A cada uno se le repartirá un relato diferente de mujeres que han interrumpido su embarazo.

Se propondrá a cada grupo que trabaje entorno al acceso real a servicios, vulneración de derechos (si lo hubiera), marco legal, entre otros.

Luego se hará una puesta en común. Desde la coordinación se acompañará en la reflexión sobre la temática y en el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

Relatos:

ANDREA

Cuando le dije a mi novio sobre el embarazo se alejó totalmente de mí. Aborté cuando tenía 7 semanas y 3 días. Una compañera de trabajo me acompañó en el proceso. Hablé con una amiga, quien me dio el nombre de unas pastillas, busqué información en internet sobre éstas, y hablaban de un 96% de efectividad, pero requerían de mucho cuidado y hablaba de mucho sangrado durante 6 u 8 semanas, y también encontré la parte donde decía que debería de tener contacto profesional, por si hubiera hemorragia éste pudiera pararla.

JUANA

Tenía 18 años y estaba en el último curso de secundaria. Me había separado recientemente de mi novio después de tres años. Tuve mucha dificultad con el aborto porque un quiste en mi ovario hizo que los medicamentos que tomé no funcionaron, aún después de varios intentos.

LOURDES

Me embaracé a mis 16 años. Tenía una relación nada segura con mi novio. Estaba a punto de ir con un doctor que se veía fraudulento, pero era la única opción que tenía.

SANDRA

Yo tengo un hijo. Aborté con medicamentos a los dos meses porque el bebé no era de mi pareja, no funcionaron las pastillas. Decidí ir al ginecólogo y la Dra. era una persona joven. Tomé fuerzas para explicarle mi caso. Ella me explicó los riesgos que corría si provocaba un aborto, me dijo que ya era demasiado tarde que no podía hacer ella nada y me refirió a un lugar para que me hagan terapia para que me ayude a querer al bebe cuando nazca, que mi vida cambiaría pero que tendría solución, que fuera feliz con él, que será un compañero para mi hijo y muchas cosas de ese tipo.

TANIA

Yo me embaracé cuando estaba estudiando. Había estado usando protección y no me di cuenta hasta que tenía 18 semanas. El médico dijo que como yo tenía 18 semanas no se podía hacer nada, me recomendó que me cuide y dio la posible fecha de parto.

ACTIVIDAD PARA EL AULA

"Análisis 2"

Objetivo: Análisis sobre el acceso a servicios de salud para las y los jóvenes en su entorno.

Nivel: Secundaria

Tiempo aproximado: 45 minutos, 2 sesiones separadas.

Desarrollo:

Realizamos una investigación participativa con las y los estudiantes, en los centros de salud sobre la atención diferenciada para adolescentes y jóvenes en la comunidad:

1. Elaboramos y aplicamos los instrumentos de recolección de información (encuestas, entrevistas, entre otros.)
2. Sistematizamos los resultados y junto a las y los estudiantes, identificamos, analizamos y priorizamos los principales problemas en torno al acceso a los servicios de salud.
3. Elaboramos un informe sobre resultados y análisis de la información recopilada que será presentado en la etapa de socialización. Elegimos diferentes medios para presentar.

Elegimos una de las siguientes opciones para presentar los trabajos realizados:

- Organizados en grupos comunitarios socializamos los trabajos elaborados. Con el apoyo de la/el facilitador realizamos la valoración de aspectos.
- De manera individual en plenaria presentamos los trabajos realizados.

ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO

Tomando en cuenta el área de saber y conocimiento que tiene como maestra o maestro, analizar e identificar en la Planificación Trimestral un contenido o tema en el que se pueda incorporar uno o varios de los contenidos desarrollados.

Nota. - Mayores recursos didácticos para primaria y secundaria se pueden encontrar en los siguientes QRs.

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA

Mira el PDF: "***Guía de formación integral para estudiantes Educación Integral en Sexualidad***" de: Coordinadora de la Mujer.

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA

Mira el PDF: "***Guía de educación integral sexual para secundaria, para la prevención de la violencia de género***" de: CIES.

BIBLIOGRAFÍA

CIES. (2007). Para Vivir Nuestra Sexualidad. La Paz: CIES.

Congreso Mundial de Orientación y Asesoramiento (2000). Declaración. Valencia: Congreso Mundial de Orientación y Asesoramiento.

Hernández Poveda, R. (2002). Aprendamos a elaborar exámenes escritos. Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia.

Instituto Nacional de Estadística. (2017). Encuesta de Demografía y Salud Bolivia: Indicadores Priorizados. Bolivia: INE.

Vygotskii, L.S. (2012). Paidología del adolescente. Problemas de la psicología infantil. Moscu: Antonio Machado Libros.

Margulis, L., & Sagan, D. (2000). What is life?. California: University of California

Merino, Carmen. (1993). Identidad y Plan de Vida en la Adolescencia. México: Perfiles Educativos.

Martin Cisneros, L., & Ramírez Aúz, M. (2014). La Evaluación De Las Destrezas Orales. Reino Unido: Centro Virtual Cervantes.

Ministerio de Educación. (2014). Unidad de Formación Nº 4 "Medios de enseñanza en el Aprendizaje comunitario" Planificación Curricular. La Paz, Bolivia : Equipo PROFOCOM.

Ministerio de Educación - PROFOCOM. (2015). Cuaderno de Concreción Unidad de Formación N°11: Educación Inicial. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación. (2013). Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular - Resolución Ministerial N° 143/2013. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación. (2014). Educación Inicial en Familia Comunitaria: Lineamientos y Orientaciones Metodológicas y Programas de Estudio. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación. (2014). Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.